

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – CAMPUS DE CASCAVEL
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE - MESTRADO

SALUHU IBRAHIM

**REPERCUSSÕES MENTAIS E FÍSICAS EM IDOSOS APÓS INTERNAÇÃO
NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA POR COVID-19**

CASCAVEL-PR
(2026)

SALUHU IBRAHIM

**REPERCUSSÕES MENTAIS E FÍSICAS EM IDOSOS APÓS INTERNAÇÃO NA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA POR COVID-19**

DISSERTAÇÃO apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde – Mestrado, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Biociências e Saúde.

Área de concentração: Biologia, processo saúde-doença e políticas de saúde

ORIENTADORA: Prof^a Dr^a Rosa Maria Rodrigues

COORIENTADORA: Prof^a Dr^a Gicelle Galvan
Machineski

CASCADEL-PR
(2026)

AUTORIZO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES TRABALHOS, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

Assinatura:  Data 10 / 03 / 2026

O presente estudo foi realizado com auxílio da CAPES através do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) pelo Auxílio Financeiro a Projeto Educacional ou de Pesquisa (AUXPE), com processo de número 88881.594204/2020-01, com auxílio número 1359/202.

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Ibrahim, Saluhu
Repercussões mentais e físicas em idosos após internação na unidade de terapia intensiva por covid-19 / Saluhu Ibrahim; orientadora Rosa Maria Rodrigues; coorientadora Gicelle Galvan Machineski. -- Cascavel, 2026.
76 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Cascavel) -- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Programa de Pós-Graduação em BioCiências e Saúde, 2026.

1. Biociências. 2. Saúde. I. Rodrigues, Rosa Maria, orient. II. Machineski, Gicelle Galvan, coorient. III. Título.



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria
CNPJ 78.680.337/0001-84
Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário
Tel.: (45) 3220-3000 - www.unioeste.br
CEP: 85819-110 - Cx. P.: 701
Cascavel - PARANÁ



SALUHU IBRAHIM

**REPERCUSSÕES MENTAIS E FÍSICAS EM IDOSOS APÓS INTERNAÇÃO NA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA POR COVID-19**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde em cumprimento parcial aos requisitos para obtenção do título de Mestre em Biociências e Saúde, área de concentração Biologia, processo saúde-doença e políticas de saúde, linha de pesquisa Práticas e políticas de saúde, APROVADO(A) pela seguinte banca examinadora:

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSA MARIA RODRIGUES
Data: 13/03/2026 13:38:18-4306
Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

Orientador(a) - Rosa Maria Rodrigues

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
gov.br SOLANGE DE FATIMA REIS CONTERNO
Data: 13/03/2026 08:27:13-0330
Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

Solange de Fatima Reis Conterno

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
gov.br LEILA RUTE OLIVEIRA GURGEL DO AMARAL
Data: 12/03/2026 20:01:47-9100
Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

Leila Rute Oliveira Gurgel do Amaral

Universidade Federal do Tocantins

Cascavel, 9 de março de 2026

DEDICATÓRIA

Aos meus pais,
À minha esposa, Maria de Lourdes Gracino dos Santos,
Às minhas orientadoras, Dra. Maria Rosa Rodrigues e Dra. Gicelle Galvan
Machineski.

AGRADECIMENTO

Primeiramente, agradeço a Deus por me conceder a força e a sabedoria necessárias para superar os desafios.

Aos meus pais, pela educação, apoio e amor incondicional, que são a base de tudo.

Aos meus professores, principalmente, minhas orientadoras: Dra. Maria Rosa Rodrigues e Dra. Gicelle Galvan Machineski, pela orientação, apoio e conhecimento compartilhado, que foram fundamentais para o meu crescimento acadêmico.

À minha esposa, Maria, pelo amor, apoio incondicional e compreensão ao longo dessa jornada.

Aos meus amigos, pelo incentivo e companheirismo.

À UNIOESTE e ao programa de mestrado em Biociências e Saúde, pela oportunidade de aprender e desenvolver este trabalho.

RESUMO

O vírus da Covid-19 é altamente contagioso e possui fácil penetração através das vias aéreas, atacando inicialmente os pulmões e se expandindo para outros órgãos, com grande potencial de causar danos e provocar a morte. Os sintomas comuns são dores de cabeça, dores de garganta, sintomas gripais, febre, tosse, fadiga, dispneia, cansaço, perda de paladar, obstrução nasal, secreção nasal, náuseas e vômito e problemas digestivos, como diarreia. Além disso, dispõe do potencial de atravessar a barreira hematoencefálica, tendenciando tribulações neurais que podem persistir por dias, semanas, meses ou por um período mais longo, o que acarreta vários problemas, a exemplo de depressão, ansiedade, esquecimento e insônia, sendo os longevos os mais afetados, devido à imunodeficiência e às condições crônicas. O objetivo deste estudo foi conhecer a percepção dos idosos que foram internados na Unidade de Terapia Intensiva, devido à infecção por vírus da Covid-19, sobre as repercussões mentais e físicas após a infecção. Metodologia: Trata-se de um estudo, exploratório, descritivo e de campo, com uma abordagem qualitativa, realizado com idosos que foram internados na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital universitário, localizado na região oeste do Paraná. Para tanto, foi realizada a busca de dados nos prontuários eletrônicos dos idosos, os quais foram diagnosticados e internados na Unidade de Terapia Intensiva por Covid-19, e efetuadas entrevistas semiestruturadas, as quais foram gravadas com dispositivo MP3, validadas pelos participantes, transcritas e analisadas por meio de método de Bardin. Resultados: O estudo foi realizado com 11 participantes, com idade entre 64 e 80 anos. Os achados indicaram que a maioria dos idosos eram do sexo feminino (54,54%), com idade variando entre 70 e 80 anos (63,64%), de cor branca (54,55%), casados (45,45%), ensino fundamental completo (90,90%), aposentados e com renda equivalente a um salário-mínimo (90,90%). Todos os participantes relataram algum tipo de prejuízo decorrente da Covid-19, com impactos variados, sendo que alguns apresentaram consequências mais acentuadas no âmbito mental, enquanto outros tiveram repercussões mais significativas no aspecto físico. Considerações finais: O estudo evidenciou alterações psicológicas, emocionais e físicas causadas pela Covid-19. Diante disso, torna-se imperativo direcionar atenção especializada a esse público para mitigar as consequências a longo prazo.

Palavras-chave: saúde mental; força muscular; idoso; covid-19; hospitalização.

ABSTRACT

MENTAL AND PHYSICAL REPERCUSSIONS OF ELDERLY AFTER HOSPITALIZATION IN THE INTENSIVE CARE UNIT DUE TO COVID-19

The Covid-19 virus is highly contagious and easily penetrates the airways, initially attacking the lungs and spreading to other organs, with a high potential to cause damage and death. Common symptoms include headaches, sore throats, flu-like symptoms, fever, cough, fatigue, dyspnea, tiredness, loss of taste, nasal congestion, nasal discharge, nausea and vomiting, and digestive problems such as diarrhea. Furthermore, it has the potential to cross the blood-brain barrier, leading to neural disturbances that can persist for days, weeks, months, or even longer, resulting in various problems such as depression, anxiety, forgetfulness, and insomnia. The elderly are the most affected due to immunodeficiency and chronic conditions. The objective of this study was to understand the perception of elderly individuals admitted to the Intensive Care Unit due to Covid-19 infection regarding the mental and physical repercussions after infection. Methodology: This is an exploratory, descriptive, and field study with a qualitative approach, conducted with elderly individuals who were admitted to the Intensive Care Unit of a university hospital located in the western region of Paraná. Data was retrieved from the electronic medical records of elderly individuals diagnosed with and admitted to the Intensive Care Unit due to Covid-19. Semi-structured interviews were conducted, recorded with an MP3 player, validated by the participants, transcribed, and analyzed using Bardin's method. Results: The study included 11 participants aged between 64 and 80 years. The findings indicated that the majority of the elderly were female (54.54%), aged between 70 and 80 years (63.64%), white (54.55%), married (45.45%), with completed primary education (90.90%), retired, and with an income equivalent to one minimum wage (90.90%). All participants reported some type of impairment resulting from Covid-19, with varying impacts, some presenting more pronounced consequences in the mental sphere, while others had more significant repercussions in the physical aspect. Final considerations: The study evidenced psychological, emotional and physical changes caused by Covid-19. Therefore, it is imperative to direct specialized attention to this population to mitigate the long-term consequences.

Keywords: mental health; muscle strength; elderly; covid-19; hospitalization.

LISTA DE ABREVIATURAS

ACS	Agentes Comunitários de Saúde
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CAPS	Centros de Atenção Psicossocial
CCIH	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
CEPEH	Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos
CJM	Colônia Juliano Moreira
CoVs	coronavírus
CPPII	Centro Psiquiátrico Pedro II
DINSAM	Divisão Nacional de Saúde Mental
DSM	Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais
<i>DZIF</i>	<i>German Center for Infection Research</i>
ESPIN	Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
MERS	Síndrome Respiratória do Oriente Médio
MHF	<i>Mental Health Foundation</i>
NIH	<i>National Institute of Health</i>
OMS	Organização Mundial da Saúde
OPAS	Organização Pan-Americana da Saúde
PNI	Programa Nacional de Imunizações
PTG	Crescimento Pós-Traumático
RT-PCR	polimerase com transcriptase reversa
SARS	Síndrome Respiratória Aguda Grave
SNC	Sistema Nervoso Central
SUS	Sistema Único de Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UBS	Unidade Básica de Saúde
UNIOESTE	Universidade Estadual do Oeste do Paraná
WHO	<i>World Health Organization</i>
UTI	Unidade de Terapia Intensiva

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	11
2. OBJETIVOS	15
2.1 . Objetivo Geral	15
2.2. Objetivos Específicos	15
3. REVISÃO DE LITERATURA.....	16
3.1. A pandemia por coronavírus SARS-CoV-2.....	16
3.2. Saúde mental.....	20
4. METODOLOGIA.....	25
4.1 Tipo de estudo.....	25
4.2. Local do estudo.....	25
4.3 População e amostra.....	25
4.4 Coleta de dados.....	26
4.5 Sistematização e Análise dos Dados.....	27
4.6 Aspectos Éticos do Estudo.....	28
6. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	29
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	51
REFERÊNCIAS	
APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS	
APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)	
APÊNDICE C - ARTIGO PARA PUBLICAÇÃO	
ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP	
ANEXO 2 – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO PARA PUBLICAÇÃO	

1 INTRODUÇÃO

A pandemia da Covid-19, principiada na China, em dezembro de 2019 (WHO, 2020a), ensejou uma colossal consequência à saúde da população em todo o mundo (Cuadrado *et al.*, 2024). O SARS-CoV-2 é um vírus altamente contagioso e possui fácil penetração através das vias aéreas, de forma que ataca inicialmente os pulmões e se expande para outros órgãos, com grande potencial de causar danos e levar à morte (Yang *et al.*, 2020). Alguns fatores, como idade avançada, obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças pulmonares e cardíacas, desfavorecem o prognóstico (Williamson, 2020).

Estima-se que até o dia 10 de março de 2023, 6.881,955 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 mundialmente (*Coronavirus Resource Center*, 2023). No Brasil, entre março de 2020 a dezembro de 2021, foram registradas 628.689 mortes decorrentes desse vírus (Silva Filho *et al.*, 2024). Entretanto, no dia 05 de maio de 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o fim da pandemia (Zhang *et al.*, 2024), graças às vacinas contra o microrganismo (Bernal *et al.*, 2021).

Uma das populações mais afetadas no período desse surto foram os idosos (Silva Filho *et al.*, 2024). Sabe-se que o envelhecimento, naturalmente, traz consigo transformações que acarretam fragilidade ao corpo físico e sistema imunológico do idoso. Ademais, permite o desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, problemas cardíacos, dentre outras, que, por consequência, potencializam outras enfermidades, a exemplo da Covid-19 (Saraiva *et al.*, 2020).

Na fase abrupta da infecção da Covid-19, os sintomas associados são variados e abrangentes, sendo frequentes dores de cabeça, dores de garganta, sintomas gripais, como febre, tosse, fadiga, dispneia, cansaço, perda de paladar, obstrução nasal, secreção nasal, náuseas e vômitos e problemas digestivos, a saber, diarreia (CDC, 2024). Além disso, observaram-se casos de perda de memória e redução da capacidade cognitiva em alguns pacientes, mesmo após tratamento e cura (Furtado *et al.*, 2023).

A literatura revela que o vírus, além da capacidade de engendrar danos a outros órgãos, dispõe do potencial de atravessar a barreira hematoencefálica, tendenciando tribulações neurais que podem persistir por dias, semanas, meses ou por um período mais longo, a depender da gravidade incidida ao paciente (Ousseiran; Fares; Chamoun, 2023). A anosmia (perda de olfato) é um dos sintomas neurológicos com

frequente aparecimento (Ahmed *et al.*, 2020), porém, podem surgir outros, como déficits de atenção, ansiedade, depressão, psicose e insônia (Alkodaymi *et al.*, 2022).

Diante desse quadro, neste estudo, vislumbra-se explorar as repercussões mentais e físicas da Covid-19 em idosos que foram internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à infecção pelo vírus. O período pós-Covid é dividido em duas fases: fase aguda – a extensão de sequelas da doença entre 3 a 12 semanas após cura, e fase crônica – a partir de 12 semanas, com a persistência de sintomas, descartando causas alheias (Greenhalgh *et al.*, 2020). Verificou-se a existência significativa de problemas neurais nas duas fases, considerando todas as faixas etárias (Alsagheir *et al.*, 2023).

No entanto, há ainda incertezas no que se refere à eventual instalação permanente das sequelas ou à possibilidade de recuperação com o passar do tempo (Montani *et al.*, 2022). Diante disso, ciente de que os longevos são mais frágeis e possuem uma recuperação mais prolongada, justamente por serem majoritariamente imunodeficientes (Williamson *et al.*, 2020), e, levando em consideração o aumento de expectativa de vida no mundo (United Nations, 2022) e no Brasil (Brasil, 2024), além da necessidade de proporcionar uma qualidade de vida para esse público, decidiu-se explorar mais a fundo tal fenômeno.

A saúde mental decorre de uma complexa combinação de elementos biológicos, psicológicos e sociais. Aspectos biológicos, como condição física, hereditariedade, alimentação saudável, padrões de sono e idade, têm impacto direto no funcionamento do cérebro e no equilíbrio emocional (Blows, 2022; Lim *et al.*, 2016). No âmbito psicológico, crenças, condições de saúde mental, visão pessoal e dependências moldam a resposta individual a situações e sentimentos (Rozman; Vrecko; Tominc, 2025).

Os fatores sociais, por sua vez, que envolvem relacionamentos interpessoais, dinâmica familiar, contexto cultural, condições de trabalho, situação financeira e acesso à moradia adequada, desempenham um papel crucial no suporte e nas pressões enfrentadas pelo indivíduo, destacando a importância de um ambiente favorável para a promoção da saúde mental (MHF, 2022).

A depressão e ansiedade figuram como as principais doenças mentais na atualidade, apresentando alta prevalência em todos os países e comunidades, além de afetar pessoas de todas as faixas etárias e níveis socioeconômicos. Elas constituem a segunda maior causa de incapacidade prolongada, ficando atrás

somente das doenças cardiovasculares, o que resulta em perda significativa de qualidade de vida (WHO, 2025b; Pozzobon *et al.*, 2024).

Esses transtornos elevam os custos de saúde para os afetados e suas famílias, além de gerar impactos econômicos consideráveis à saúde pública. A incidência desses distúrbios pode variar conforme o sexo, sendo as mulheres geralmente mais impactadas. O suicídio é uma consequência trágica da depressão e ansiedade, que tirou aproximadamente 727.000 vidas, em 2021, representando uma das principais causas de morte entre jovens globalmente (WHO, 2025b).

Além da depressão e ansiedade, uma gama de transtornos mentais, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno Bipolar, Esquizofrenia, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), Transtornos Alimentares e Estresse Pós-Traumático (TEPT), exige atenção do poder público e engajamento da sociedade. Esses problemas afetam significativamente a qualidade de vida, relações e produtividade, ressaltando a importância de políticas eficazes, conscientização e acesso a tratamentos para promover inclusão e reduzir estigmas associados à saúde mental (NIH, 2024).

Atualmente, estima-se que 450 milhões de pessoas no mundo sofram de transtornos mentais, o que representa 12% da carga global de doenças, com a previsão de aumentar para 15% até 2030, especialmente, devido à disposição crônica e debilitante da depressão e de outros distúrbios psiquiátricos comuns (Facundes; Silva; Pirozzi, 2023).

Em 2019, constatou-se que, pelo menos uma em cada oito pessoas, ou 970 milhões de pessoas, vivia com um transtorno mental, mundialmente considerando, de maneira que os transtornos de ansiedade e depressão são os mais prevalentes, os quais escalaram, de forma significativa, em 2020, devido à pandemia da Covid-19 (OMS, 2022).

De acordo com a OMS, aproximadamente 14% dos idosos com 60 anos ou mais convivem com algum transtorno mental. Esses transtornos respondem por 10,6% da incapacidade total nessa faixa etária. Depressão e ansiedade são os mais comuns entre esse público. Globalmente, cerca de um quarto (27,2%) das mortes por suicídio ocorre em pessoas com 60 anos ou mais (WHO, 2023).

Ressalta-se que a garantia da saúde mental, independentemente da idade, é crucial para a conservação de uma vida saudável; assim, fornecer cuidado aos idosos exige, para além do tratamento direcionado à condição biológica, ponderar os

aspectos psicológicos e sociais, envolvendo ações multiprofissionais, como a psicologia e assistência social (Pereira *et al.*, 2023). Isso visa proporcionar equilíbrio entre físico e psicológico, propiciando autonomia, autocuidado e socialização (Campos *et al.*, 2024).

Além disso, a Covid-19 pode ter impactos importantes na saúde física dos infectados, tanto direta quanto indiretamente. A infecção pode desencadear respostas inflamatórias que afetam o sistema musculoesquelético, causando danos pulmonares, cardíacos e musculares, levando a sintomas, como fraqueza, dor e fadiga (Huang *et al.*, 2020).

A internação hospitalar prolongada é outro fator que contribui para a perda de saúde física. A imobilidade prolongada e o uso de ventilação mecânica podem ocasionar a fraqueza muscular e problemas respiratórios, dificultando a recuperação e aumentando o risco de complicações futuras. Isso destaca a importância de intervenções precoces, como a mobilização e a fisioterapia, para minimizar esses efeitos (Pierre *et al.*, 2025).

O isolamento social também desempenha um papel importante na perda de saúde física. A redução da atividade física durante o isolamento pode contribuir para a perda de força muscular e aumento do risco de doenças crônicas (Araújo *et al.*, 2022).

Perante o exposto, questiona-se: qual a percepção dos idosos acometidos pelo vírus da Covid-19 sobre a saúde mental e física após a infecção? Por conseguinte, acredita-se que este estudo pode ajudar a vislumbrar queixas de falhas de memória, percepção de aumento de ansiedade, depressão e insônia, além de problemas físicos, como fraqueza muscular. Além disso, deve contribuir para os avanços científicos na área de saúde coletiva e saúde mental, bem como para as práticas de saúde.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Analisar a percepção dos idosos que foram internados na UTI, devido à infecção por vírus da Covid-19, sobre a sua saúde mental e física após a infecção pelo vírus.

2.2 Objetivos Específicos

Caracterizar o perfil sociodemográfico, econômico e de saúde de idosos que foram hospitalizados devido à infecção pela Covid-19.

Descrever a percepção de idosos sobre a sua saúde mental e física após a infecção pela Covid-19.

Conhecer as percepções dos idosos sobre mudanças emocionais e comportamentais após a infecção pela Covid-19.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 A pandemia por coronavírus SARS-CoV-2

Os coronavírus (CoVs) representam o maior grupo de vírus da ordem Nidovirales, que abrange a Família Coronaviridae, Arteriviridae, Mesoniviridae e Roniviridae (Fehr; Perlman, 2015). São vírus zoonóticos, predominantemente provenientes de morcegos, considerados um dos seus principais reservatórios naturais, com capacidade de suscitar aflições respiratórias em seres humanos e animais (Brasil, 2022a). Até o momento, foram constatados sete tipos de coronavírus: alfa coronavírus HCoV-229E e HCoV-NL63, beta coronavírus HCoV-OC43 e HCoV-HKU1, SARS-CoV (causador de síndrome respiratória aguda grave ou SARS), MERS-CoV (ocasionador de síndrome respiratória do Oriente Médio ou MERS) e SARS-CoV-2, um novo coronavírus identificado no final de 2019, na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, que resultou na pandemia de Covid-19 (Brasil, 2022b).

A SARS foi inicialmente detectada em novembro de 2002, na província de Guangdong, na China. O vírus rapidamente se disseminou para vários países, incluindo Canadá, Singapura e Vietnã, transmitido por viajantes que retornavam de áreas afetadas. Em cinco meses, foram registrados 8439 casos e 812 óbitos decorrentes da doença em um total de 30 países. A transmissão ocorreu por meio do ar através de partículas respiratórias (na fala, em espirros ou na tosse), bem como pelas secreções contaminadas que entram em contato com as mucosas. Foi possível controlar a disseminação desse vírus em julho de 2003, mediante a implementação de rigorosas medidas de saúde pública, incluindo hospitalização e isolamento de pacientes suspeitos, aplicação de quarentena e divulgação de alertas de viagem (WHO, 2003).

A SARS tem capacidade de infectar tanto animais quanto seres humanos; contudo, em animais, a doença geralmente se manifesta de forma branda e atenuada, enquanto, nos humanos, ela tende a apresentar-se com maior severidade. Tal diferença na suscetibilidade e no espectro clínico sugere que os mecanismos de interação do vírus com os hospedeiros variam consideravelmente, evidenciando a complexidade associada à patogênese do SARS-CoV (Subbarao; Robert, 2006).

O período de incubação da SARS varia entre 2 e 14 dias; assim, as vítimas geralmente manifestam sintomas semelhantes aos da gripe, os quais podem evoluir

para pneumonia, insuficiência respiratória e, em casos graves, insuficiência renal e hepática, levando até à morte. Entre os sintomas comuns, estão dor de cabeça, diarreia, calafrios, febre, mal-estar geral, fadiga, dispneia, tosse, mialgia e manchas avermelhadas na pele (exantemas). Manifestações neurológicas, como confusão mental e cefaleia, também foram detectadas (Bruna, 2022).

Em relação ao MERS-CoV, sua primeira identificação aconteceu na Arábia Saudita, em junho de 2012, com subsequente disseminação para 27 países. Até a data de 21 de julho de 2013, um total de 90 casos havia sido confirmado globalmente, dos quais 45 resultaram em óbito. Pesquisas indicaram que a infecção humana ocorreu mediante contato direto ou indireto com camelos dromedários infectados. Acredita-se que a transmissão ocorreu por meio de exposição a gotículas respiratórias, saliva e tecidos respiratórios de camelos, especialmente durante práticas, a exemplo de abate e consumo de produtos derivados, incluindo leite, urina e carne de camelo insuficientemente cozida (WHO, 2022b; Assiri *et al.*, 2013).

A transmissão do MERS-CoVs entre seres humanos acontece principalmente entre indivíduos com contato próximo e dentro de ambientes de assistência à saúde, abrangendo familiares e moradores do mesmo domicílio, trabalhadores da saúde e outros pacientes. Os surtos de maior magnitude foram registrados em estabelecimentos de saúde localizados na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e República da Coreia. Cerca de 80% dos casos humanos documentados provêm da Arábia Saudita, o que reflete, em grande medida, o contato direto ou indireto com camelos dromedários infectados ou com pessoas infectadas em contextos hospitalares. Fora da região do Oriente Médio, os relatos de surtos são escassos. Estima-se que, aproximadamente, 35% dos casos notificados de MERS tenham evoluído para óbito (WHO, 2022b).

O MERS-CoV apresenta um período de incubação médio que varia de 5 a 7 dias, embora casos com intervalos entre 14 e 22 dias tenham sido documentados. A manifestação clínica dessa infecção abrange, desde formas completamente assintomáticas, até doenças leves e graves, estas últimas podendo evoluir para falência de múltiplos órgãos (Virlogeux *et al.*, 2016).

Nos pacientes sintomáticos, os sinais e sintomas iniciais, frequentemente, incluem febre, calafrios, tremores, dor muscular, mal-estar geral, tosse e dificuldade respiratória. Além disso, sintomas gastrointestinais, a saber, diarreia, vômitos e dor abdominal, podem se manifestar como parte do quadro respiratório ou constituir a

principal queixa. A pneumonia é uma apresentação comum. As formas graves da infecção tendem a acometer, predominantemente, indivíduos idosos com condições mórbidas associadas, evoluindo com insuficiência respiratória aguda, falência renal e estado de choque (Assiri *et al.*, 2013). A prevenção da disseminação do vírus ocorre por meio de isolamento social, quarentena, uso de máscaras cirúrgicas e cobrir a boca ao tossir (Baharoon; Memish, 2019).

Vale salientar que não existem ainda vacinas aprovadas e nem tratamentos específicos eficazes para a SARS e o MERS, no entanto, há pesquisas e testes clínicos em andamento que visam ao desenvolvimento de vacinas e terapias que possam combater esses vírus (Dzif, 2024; Tan *et al.*, 2021; Opas, 2018).

No que diz respeito ao novo coronavírus, foi nomeado oficialmente como Covid-19, pela OMS, após sua identificação. A nomenclatura Covid denota *Corona Virus Disease* (doença do coronavírus), designado assim devido às espículas em sua superfície, que se caracteriza por uma coroa (do latim "corona"), e o número "19", referindo-se ao ano de 2019 (Brasil, 2020a).

Os primeiros casos da doença, no Brasil, foram detectados em fevereiro de 2020, o que fez com que o governo federal declarasse Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). Assim, consequentemente, foi necessário implementar diversas medidas, a exemplo de provisionar contratos de serviços, elevar acesso aos diagnósticos e tratamentos, estabelecer medidas de prevenção, traçar métodos de desenvolvimento e distribuição de vacinas, dentre outros aspectos; isso visando controlar e mitigar o alastramento da doença no país (Brasil, 2020b).

Todavia, com o avanço rápido do vírus, em praticamente todos os continentes, e o significativo número da infecção e mortalidade que ocasionava, no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou a Covid-19 como uma pandemia. Dessa forma, resultou em intensificação das medidas preventivas em todo o mundo, a fim de atenuar a sua propagação (WHO, 2020b).

Ciente das principais vias de disseminação do vírus (vias respiratórias: gotículas, ou contato com mucosas: olho e boca), os poderes públicos estabeleceram medidas essenciais, como evitar aglomerações, manter distância entre pessoas, permanecer em casa e sair apenas em casos de necessidade. Assim, foi considerada a adoção do isolamento social, recomendação de uso de máscaras e luvas, especialmente, quando necessário sair de casa; higienização e uso de álcool nas

mãos, fechamento de estabelecimentos, mantendo apenas os essenciais, a exemplo de serviços de saúde e alimentícios (Brasil, 2020c; Uzunian, 2020).

A despeito do período de incubação do vírus, apesar de existirem casos em que os sintomas aparecem já nas primeiras 24 horas, após a contaminação, o tempo mais prevalente é entre 5 a 14 dias; assim, os indivíduos, que entraram em contato com uma região ou pessoas infectadas, permaneciam isolados até o término do referido período para esclarecimento (quarentena), visto que se sabe que as pessoas assintomáticas transmitem a doença tanto quanto os sintomáticos (Oliveira; Oliveira, 2021; Brandenburg *et al.*, 2020; Assis *et al.*, 2020).

Existem duas principais formas de estabelecer o diagnóstico: a primeira envolve a detecção do material genético do vírus por meio da reação em cadeia da polimerase com transcriptase reversa (RT-PCR), utilizando amostras de secreções nasais e orofaríngeas; a segunda é a busca e reconhecimento de anticorpos presentes no soro de pacientes supostamente infectados, um método conhecido como sorologia para SARS-CoV-2 (Uzunian, 2020).

No que diz respeito ao tratamento, no início da pandemia, tratava-se apenas de métodos preventivos, pois não havia comprovação concreta sobre o tratamento; por isso, recomendou-se o uso de paracetamol, dipirona, antitérmicos e consumo frequente de líquidos (Do Bú *et al.*, 2020). Juntamente a isso, despontou a corrida em busca de vacinas contra o vírus. Ainda em 2020, algumas vacinas obtiveram aprovação para uso emergencial em certos países da Europa e nos Estados Unidos; em 17 de janeiro de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no Brasil, concedeu a permissão para o uso emergencial das vacinas CoronaVac e AstraZeneca (Castro, 2021).

Com a adesão imensa da população nas vacinações, observou-se a queda drástica da transmissão do vírus, com uma maior eficácia na redução da disseminação em indivíduos que completaram o ciclo vacinal, resultando, assim, a declaração do fim da pandemia, pela OMS, no dia 5 de maio de 2023 (Medeiros *et al.*, 2023; Zhang *et al.*, 2024).

A Covid-19 acarretou o desenvolvimento de uma série de problemas na saúde da população mundial, destacando-se os distúrbios mentais (Moayed *et al.*, 2021). Dessa maneira, a OMS define a saúde mental como o estado de bem-estar, no qual o indivíduo reconhece suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e é capaz de contribuir para sua comunidade.

Refere, ainda, que a saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais, pois é uma parte integral e essencial da saúde geral (OMS, 2022).

Não obstante, estudos demonstram que os coronavírus apresentam um potencial de neurotropismo, ou seja, possuem capacidade de invadir o Sistema Nervoso Central (SNC) e provocar doenças neurológicas (Mendonça Filho *et al.*, 2023). Esse neurotropismo sugere que as implicações dos CoVs vão além dos sintomas respiratórios típicos, podendo acarretar repercussões neurológicas e psiquiátricas, o que inclui declínio cognitivo, distúrbios do sono, disfunção olfativa, ansiedade e depressão, um campo que demanda maior atenção e investigação para melhor compreensão dos seus impactos e potenciais consequências para a saúde mental (Tavares Júnior *et al.*, 2024; Cataldi; Pignataro; Taglialatela, 2020).

3.2 Saúde Mental

A compreensão e caracterização dos transtornos mentais têm passado por uma evolução significativa ao longo dos anos, refletindo mudanças culturais, científicas e sociais (Arthur *et al.*, 2022). Pode parecer contraintuitivo para os padrões atuais, mas é possível afirmar que a experiência com a loucura nem sempre foi vista como algo negativo ou classificada como doença. Ao contrário, na Grécia Antiga, ela chegou a ser considerada um privilégio, quando os indivíduos considerados "loucos" eram tidos como santos, imbuídos de espírito divino, os quais atuavam como uma ponte entre os homens e os deuses (Pelbart, 1989).

Na baixa Idade Média, mais especificamente no contexto do século XV, a concepção sobre a loucura sofreu uma transformação profunda, atribuindo-se comportamentos desviantes à possessão demoníaca, e não mais à influência divina, como na Grécia antiga. Como resultado, promoveram-se perseguições que culminaram na execução de pessoas consideradas histéricas ou alucinadas, vistas como possuídas. A loucura era associada a comportamentos de luxúria ou desrespeito ao sagrado, atribuindo-se a atuação do demônio ao corpo e ambiente, o que provocava diversos sintomas, como alucinações, mudez, paralisias e cegueiras (Pessotti, 1999).

O século XVIII, conhecido como o Século das Luzes, foi um período em que a loucura passou a ser definitivamente apreendida como objeto do saber médico, caracterizando-se como doença mental e considerada passível de cura. Num contexto

de valorização da razão e do pensamento científico, o hospital emergiu como espaço terapêutico. Nesse período, o avanço da fisiologia e da anatomia patológica permitiu classificações de distúrbios mentais, com termos como mania e melancolia sendo utilizados para descrever problemas mentais (Silveira; Braga, 2005; Pessotti, 1999).

Todavia, apesar de o século XVIII ter sido um período importante no desenvolvimento da medicina, em relação aos transtornos mentais, foi marcado por aspectos sombrios, caracterizado por práticas de segregação e institucionalização dos pacientes psiquiátricos. Isso foi frequentemente associado a maus-tratos, o que refletia uma abordagem que misturava cuidado médico com isolamento social e, por vezes, tratamento desumano (Amarante, 1998).

No entanto, somente após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), iniciou-se um movimento em muitos países do mundo por uma reforma psiquiátrica, que conclamava, entre outras demandas, a desinstitucionalização dos indivíduos com sofrimento psíquico, a exemplo, a experiência de Franco Basaglia nas cidades italianas de Gorizia e Trieste (César; Coelho, 2017).

No Brasil, a situação das pessoas com transtornos mentais não era distinta, com pacientes sendo internados em manicômios, segregados da sociedade e submetidos a condições de vida precárias (Arthur *et al.*, 2022). No entanto, assim como ocorreu na Europa, surgiu no país um movimento em defesa da reforma psiquiátrica. Um de seus marcos iniciais foi o episódio conhecido como “Crise da DINSAM” (Divisão Nacional de Saúde Mental), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, responsável pela formulação de políticas voltadas à saúde mental. Em abril de 1978, profissionais das quatro unidades da DINSAM, localizadas no Rio de Janeiro – Centro Psiquiátrico Pedro II (CPPII), Hospital Pinel, Colônia Juliano Moreira (CJM) e Manicômio Judiciário Heitor Carrilho –, entraram em greve, o que se configurou como um momento significativo no clamor por mudanças na assistência psiquiátrica brasileira (Fiocruz, 1978).

Essa luta, marcada pela noção de desinstitucionalização, ganhou impulso na segunda metade dos anos 1980, um período caracterizado por eventos diversos e importantes, incluindo a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde e da I Conferência Nacional de Saúde Mental; o II Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental (notabilizado como 'Congresso de Bauru'); a criação do primeiro Centro de Atenção Psicossocial, em São Paulo, e do primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial, em Santos; o surgimento da Associação Loucos pela Vida, no Juqueri;

a apresentação do Projeto de Lei 3.657/89 do deputado Paulo Delgado – conhecido como “Projeto Paulo Delgado” –; e a realização da 2ª Conferência Nacional de Saúde Mental (Amarante, 1998).

O Projeto de Lei 3.657/89, que foi sancionado como Lei nº 10.216/2001, visa proteger os direitos das pessoas com transtornos mentais e redirecionar o modelo assistencial em saúde mental. Essa legislação estabelece o direito à atenção integral em saúde, garantindo acesso a tratamentos e serviços de qualidade, além de promover o respeito à dignidade, autonomia e liberdade dessas pessoas. Um dos principais benefícios da Lei é a ênfase na atenção comunitária, priorizando serviços, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em detrimento de internações em hospitais psiquiátricos tradicionais. Dessa maneira, busca-se promover a reinserção social e garantir cuidado em liberdade, cidadania e autonomia aos usuários (Prandoni; Padilha, 2004; Britto; Amarante, 2007).

Hoje, devido aos avanços, pode-se afirmar que a abordagem da saúde mental segue em expansão, visando promover não apenas o bem-estar de indivíduos isolados, mas o da comunidade. Sob essa perspectiva, a terapêutica transcende o foco individual e se torna coletiva, deslocando-se de um modelo meramente assistencial para um enfoque preventivo. Independentemente da ótica adotada, é evidente que a psiquiatria passa a delinear um novo projeto, eminentemente social, cujas implicações políticas e ideológicas são profundamente significativas (Amarante, 1998). É nessa dimensão que emerge a ideia de saúde mental, ampliando a perspectiva do cuidado para além da manifestação da doença mental.

De acordo com a OMS, a saúde mental é um estado de bem-estar que capacita as pessoas a lidar com estresses, desenvolver habilidades, aprender, trabalhar e contribuir socialmente; já que é um componente integral da saúde, efetiva-se como um direito humano básico. Mais do que a ausência de transtornos, a saúde mental existe num continuum complexo e variável, experimentado de forma única por cada indivíduo, com diferentes níveis de dificuldade, sofrimento e desfechos distintos (WHO, 2025a).

Diversos determinantes individuais, sociais e estruturais, ao longo da vida, podem proteger ou comprometer a saúde mental, influenciando a posição de cada pessoa no continuum da saúde. Fatores, como habilidades emocionais, uso de substâncias e genética, podem aumentar a vulnerabilidade a problemas mentais, além de exposição a condições adversas, a exemplo da pobreza, violência, desigualdade e

degradação ambiental, que elevam o risco de comprometimento da saúde mental (WHO, 2022a).

Fatores diversos, como suporte social, capacidade de resiliência emocional, acesso a cuidados de saúde eficazes, hábitos de autocuidado, contextos seguros e estáveis, vínculos familiares e comunitários saudáveis, somados a chances de crescimento pessoal e prosperidade econômica, são fundamentais para fomentar e preservar o bem-estar mental. Tais fatores contribuem para ampliar a habilidade individual de enfrentar adversidades e minimizar riscos de desenvolver distúrbios psicológicos (WHO, 2022a).

Fomentar a saúde mental demanda uma perspectiva abrangente e colaborativa entre vários setores, visto que os fatores que influenciam o bem-estar mental, muitas vezes, vão além das fronteiras do sistema de saúde. Iniciativas exitosas de promoção e prevenção exigem a atuação conjunta de áreas diversas, como educação, mercado de trabalho, sistema judiciário, transportes, meio ambiente, moradia e serviços sociais. O campo da saúde tem um papel relevante ao integrar ações de promoção e prevenção em seus serviços, assim como ao estimular, promover e viabilizar parcerias intersetoriais, advogando por intervenções coordenadas que tenham impacto positivo na saúde mental das pessoas (OPAS, 2025).

Uma boa saúde mental está intrinsecamente atrelada ao meio social do indivíduo, envolvendo relação de emprego, família, lazer, atividade física, dentre outros, como fatores que favorecem ou não a condução da saúde mental (Sousa *et al.*, 2023). O suporte social e afetivo, fornecido por pessoas significativas, é uma dimensão crucial para o bem-estar psicológico e o desenvolvimento humano (Bronfenbrenner, 1996).

Os problemas de saúde mental podem ocorrer em qualquer etapa do ciclo de vida, sendo frequentes entre idosos. Nessa fase, destacam-se, especialmente, a depressão e a ansiedade, que podem estar associadas a diversos fatores, como condições sociais adversas — por exemplo, desemprego, baixa renda e isolamento social —, além do surgimento de doenças crônicas e das próprias mudanças físicas inerentes ao envelhecimento (Medeiros; Rabelo, 2017).

As mudanças drásticas e repentinas causadas pela pandemia criaram desafios significativos para os idosos, afetando negativamente sua saúde mental. Notou-se um aumento na incidência e agravamento de problemas psicológicos, o que resultou no desenvolvimento de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outros

transtornos mentais, além do medo, luto, aflições, incertezas, isolamento social, junto com a sensação de confinamento que contribuíram significativamente para o desconforto emocional e mental. Esses problemas destacam a necessidade de atenção especial para mitigar essas condições (Silva Filho *et al.*, 2024; Rodrigues *et al.*, 2023; Teixeira, 2023).

Outrossim, de acordo com Ousseiran, Fares e Chamoun, (2023), quanto mais severo for o quadro do paciente contaminado pela Covid-19, pior é o seu prognóstico. Dessa forma, pacientes hospitalizados pelo vírus, a depender da duração, são propensos a evoluir com problemas psiquiátricos, como a depressão, transtornos de ansiedade e estresse (Rajmohan; Aparna, 2024).

O estudo de Dias *et al.* (2023) revelou a presença de distúrbios psicológicos, principalmente, depressão em idosos hospitalizados por Covid-19, o que indica, dessa forma, a necessidade de identificação e tratamento precoce para melhorar a qualidade de vida e bem-estar desse público.

Nesse cenário, considerando o idoso como ser frágil, a internação hospitalar pode ensejar vários problemas para a sua vida, afetando diretamente a autonomia e independência. A Covid-19 tem sido responsável por largos períodos de internação dessa população, o que é agravado pelas comorbidades e pela redução da mobilidade no leito; ademais, aumenta a vulnerabilidade e complicações, tornando a hospitalização mais complexa, cujos desfechos, após a cura, podem resultar em disfunções físicas, funcionais e psicológicas (Silva *et al.*, 2022).

Posto isso, sabe-se que a tendência de surgirem mais surtos de coronavírus é uma realidade que exige atenção contínua e medidas preventivas rigorosas; a alta taxa de mutação do vírus, aliada ao aumento da circulação global de pessoas, favorece o aparecimento de novas variantes, algumas das quais podem escapar, parcialmente, da imunidade conferida por vacinas ou infecções anteriores. Isso exige, assim, investimentos em campanhas de conscientização e em infraestruturas de saúde robustas para detectar e conter, rapidamente, possíveis novos surtos, minimizando seu impacto na sociedade (Lima; Bortolini, 2022).

Assim, é importante conhecer como os idosos vivenciaram a pandemia, principalmente, aqueles que foram infectados e hospitalizados para tratamento, a fim de contribuir para a implementação de ações preventivas em novas ocorrências pandêmicas.

4 METODOLOGIA

4.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e de campo, com caráter qualitativo. Esse tipo de estudo busca compreender como um grupo social, organização etc., compreende, vive ou viveu um determinado fenômeno, que não são passíveis à interpretação por meio de variáveis matemáticas (Goldenberg, 2016). A pesquisa exploratória é definida como uma etapa preliminar da pesquisa principal, cujo objetivo é adaptar, adequadamente, o instrumento de medida à realidade ou determinado fato que se deseja investigar, muitas vezes, sucedido do trabalho descritivo. Assim, fornece amparo ao pesquisador para que possa elaborar hipóteses e métodos de abordagem (Piovesan; Temporini, 1995).

A pesquisa descritiva, por sua vez, procura descrever detalhadamente os fatos sobre a população ou dos sujeitos da pesquisa, buscando conhecer a real característica/espelho de determinado fenômeno (Trivinos, 1987). Quanto ao estudo de campo, é o cenário em que, além de realização de buscas bibliográficas e/ou documentais, o pesquisador se dirige até o loco do objeto ou a população, conhecendo pessoalmente e coletando as informações inerentes da pesquisa (Fonseca, 2002).

4.2 Local do Estudo

Os dados dos participantes foram adquiridos no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, na cidade de Cascavel, Paraná, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Anexo 1). O hospital dispõe de 363 leitos e atende exclusivamente pacientes do SUS. É um hospital de referência da região que oferece serviços especializados, principalmente, de média e alta complexidade.

A cidade de Cascavel está localizada no oeste do estado do Paraná, na região Sul do Brasil. É a quinta maior cidade do estado. De acordo com o censo do IBGE de 2022, a cidade possui uma população de 348.051 habitantes; estima-se que atinja, aproximadamente, 368.195 habitantes em 2025 (IBGE, 2022).

4.3 População e amostra

A população do estudo inclui idosos que foram internados na UTI de um hospital universitário, localizado no Oeste do Paraná, devido à infecção pelo vírus da Covid-19. Os dados dessa população foram solicitados junto ao setor da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), por meio de encaminhamento do projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPEH).

A seleção dos participantes foi efetuada por conveniência, com a obtenção da amostra quando ocorreu a saturação das informações coletadas quanto ao alcance dos objetivos (Fontanella; Ricas; Turato, 2008). Ressalta-se que a saturação ocorreu com o oitavo participante durante as entrevistas, porém, decidiu-se avançar mais um tanto para assegurar a consistência das informações obtidas. Foram incluídas, no estudo, pessoas com, no mínimo, sessenta (60) anos de idade, de ambos os sexos, que foram internados na UTI por Covid-19, e que concordaram em participar da pesquisa, sem restrições quanto à etnia, escolaridade ou classe social, além de possuir condições cognitivas preservadas para assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). Foram excluídos idosos que se encontravam com alguma enfermidade no momento da coleta, e que não possuíam as condições físicas e cognitivas para responder às perguntas, bem como aqueles que tinham diagnóstico de problemas mentais, previamente à Covid-19, como depressão, ansiedade, síndrome de pânico, demência, dentre outros.

Foram abordados 15 idosos, sendo que quatro foram excluídos, pois um apresentava incapacidade cognitiva, que limitava sua compreensão e resposta às perguntas, e três tinham diagnóstico de depressão, antes do surgimento da Covid-19, os quais ainda estavam em tratamento. Portanto, a amostra final foi composta por 11 participantes. Para facilitar o acesso às residências dos participantes, o entrevistador foi acompanhado pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), com autorização cedida pelos coordenadores das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

4.4 Coleta de dados

A coleta de dados ocorreu entre os meses de janeiro e maio de 2025, após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer nº 7.261.355 (Anexo 1). As entrevistas individuais semiestruturadas foram conduzidas, pessoalmente, pelo próprio pesquisador, in loco, nas residências dos participantes.

Uma entrevista semiestruturada é geralmente caracterizada por iniciar com perguntas básicas, fundamentadas em teorias e hipóteses relevantes para a pesquisa, que, posteriormente, oferece espaço para uma série de questionamentos adicionais, os quais surgem conforme novas hipóteses são formuladas com base nas respostas do entrevistado. Dessa forma, o entrevistado contribui espontaneamente com seu pensamento e experiências dentro do foco principal estabelecido pelo pesquisador, participando ativamente na construção do conteúdo da pesquisa (Trivinos, 1987).

As entrevistas abordaram questões sobre os dados sociodemográficos, como idade, sexo, estado civil, raça, vínculo empregatício, entre outros. Também, incluíram perguntas específicas sobre o tema do estudo, as quais questionaram a respeito das percepções dos idosos durante a pandemia da Covid-19 e como se sentem agora; como o isolamento social influenciou as suas vidas cotidianas; se conhece alguém que sofreu com a Covid-19 e de que maneira esse sofrimento afetou as suas vidas; como avaliam o funcionamento das suas memórias após infecção por Covid-19; se a infecção por Covid-19 afetou o sono (Apêndice B).

A construção e validação do instrumento de coleta de dados envolveu múltiplas etapas. Inicialmente, foram realizadas leituras abrangentes de pesquisas científicas que abordavam os efeitos da Covid-19 na saúde mental, visando fundamentar teoricamente o instrumento. Em seguida, houve discussões e adequações com a orientadora, o que contribuiu para o refinamento e ajuste das questões propostas; finalmente, foi conduzido um estudo piloto com três participantes, possibilitando testar a aplicabilidade e identificar possíveis ajustes necessários no instrumento (Benassi; Cancian; Strieder, 2023), além de averiguar possíveis adaptações necessárias para garantir que capturasse, de forma adequada, os dados relevantes sobre os impactos da Covid-19 na saúde mental dos indivíduos estudados. Não havendo a necessidade de alterações no instrumento, os participantes do estudo piloto foram incluídos na amostra principal.

4.5 Sistematização e Análise dos Dados

As perguntas e respostas foram gravadas com dispositivo MP3 e, posteriormente, transcritas por meio de *google forms* e de forma manual.

As transcrições das entrevistas foram realizadas na íntegra e, em seguida, submetidas à técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin (2016), que inclui

três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A apresentação dos dados foi organizada por categorias, o que possibilitou a classificação dos elementos que compõem o significado das mensagens. Os vícios de linguagem relacionados aos vocabulários dos participantes foram corrigidos ou eliminados. Para preservar o anonimato, os participantes foram identificados com a expressão "S", seguida de um número ordinal correspondente à ordem da entrevista (1, 2, 3...). Foram definidas três categorias: 1: Repercussões mentais e emocionais da Covid-19 na vida dos idosos; 2: Impacto físico da Covid-19 para a saúde dos idosos; e 3: O papel da espiritualidade como fonte de apoio emocional para idosos durante a pandemia de Covid-19. O software NVivo, em sua versão de avaliação gratuita, foi utilizado para a sistematização e análise dos dados (NVivo 15, 2024).

4.6 Aspectos Éticos do Estudo

A pesquisa só foi iniciada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, Parecer CEP nº 7.261.355 (Anexo 1), em conformidade com as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012, nº 580/2018 e as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, nº 13.709/2018 (Brasil, 2018a, 2018b, 2012b).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os 11 participantes, seis (54,54%) eram do sexo feminino e cinco (45,45%), masculino. Quanto à cor/raça, seis (54,55%) declararam-se brancos, três (27,27%) reconhecem-se como pardos e dois (18,18%) consideraram-se negros. A região Sul do Brasil é composta, majoritariamente, por pessoas brancas devido à imigração europeia, que teve sua maior concentração nessas localidades (Seyferth, 2002).

A faixa etária da amostra variou entre 64 e 80 anos, pois quatro (36,36%) tinham entre 64 e 69 anos, e sete (63,64%), entre 70 e 80 anos. Estudos recentes do IBGE apontam que, apesar da queda de expectativa de vida dos brasileiros, durante a pandemia de Covid-19, que era de 76,2 anos, em 2019, e caiu para 74,8 e 72,8, em 2020 e 2021, respectivamente, esse índice voltou a ascender, atingindo o patamar de 76,4 anos, em 2023 (IBGE, 2024). Projeta-se que, até 2050, aproximadamente 30% da população brasileira terá mais de 60 anos de idade (Fiocruz, 2017).

A escolaridade dos idosos participantes é preocupante, pois apenas um deles (9,09%) concluiu ensino médio completo. Os outros dez (90,90%) terminaram somente o ensino fundamental completo. Essa baixa escolaridade pode ser resultado de vários fatores, incluindo a dificuldade de acesso à educação; número reduzido de escolas; localização distante; pobreza; famílias precisavam que os filhos trabalhassem desde cedo; não valorização da educação formal. Essa combinação de fatores pode ter contribuído para a baixa escolaridade observada na maioria dos idosos. É fundamental entender esses motivos para desenvolver estratégias eficazes e melhorar a educação atual (OXFAM, 2021).

No que diz respeito ao estado civil, cinco (45,45%) eram casados, três (27,27%) viúvos, um (9,09%) era divorciado, um (9,09%) solteiro e um (9,09%) tinha um companheiro. No tocante à renda dos participantes, observou-se que a maioria, 10 (90,90%), tinha uma renda equivalente a um salário-mínimo, proveniente, principalmente, de aposentadoria, enquanto um (9,09%) não possuía renda alguma.

Relativamente à moradia, predominaram os participantes que possuíam casa própria: nove (81,82%). Além disso, um (9,09%) pagava aluguel e um (9,09%) morava com a filha. Quanto aos coabitantes, um (9,09%) morava sozinho, um (9,09%) morava com uma filha, dois (18,18%) moravam com um filho, um (9,09%) morava com cônjuge e dois netos, um (9,09%) residia com cônjuge, dois filhos e um neto, dois (18,18%)

moravam com apenas o cônjuge, um (9,09%) morava com companheiro e dois netos, um (9,09%) morava com cônjuge e um neto, e um (9,09%) morava com duas filhas.

É importante lembrar que a pandemia da Covid-19 exigiu distanciamento social, o que afetou a saúde mental de todos, mas, especialmente, de idosos, que são mais suscetíveis ao vírus e já lidam com os desafios do envelhecimento. Isso pode resultar em alterações de humor, depressão e ansiedade (Cunha *et al.*, 2022). Outrossim, no Brasil, houve aumento de idosos que residem sozinhos (Pecoits *et al.*, 2021), entretanto, o presente estudo revelou que a maioria dos idosos moravam com algum familiar, seja cônjuge, filhos ou netos. Isso pode ser um fator protetor em relação à aquisição de problema mental por isolamento social (Nakagomi *et al.*, 2023).

No que concerne à religiosidade, a maioria declarou-se católica, oito (72,72%); dois (18,18%) identificaram-se como evangélicos e um (9,09%) declarou-se espírita. De acordo com o censo do IBGE de 2022, a porcentagem de católicos, no Brasil, diminuiu de 65,1%, em 2010, para 56,7%, em 2022. Nesse mesmo período, a representação de evangélicos aumentou de 21,6% para 26,9% (IBGE, 2025). Apesar dessa queda, o catolicismo segue como a religião predominante no país (IBGE, 2025).

Em relação aos serviços de saúde que os idosos utilizam, seis (54,55%) relataram procurar apenas a Atenção Primária à Saúde (APS). Outros quatro (36,36%) afirmaram utilizar tanto a APS quanto a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já um (9,09%) possui plano de saúde privado. O artigo 196 da Constituição Federal brasileira de 1988 afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso significa que todos os brasileiros têm direito à atenção à saúde, sem qualquer tipo de barreira financeira. Dessa forma, considerando o princípio de hierarquização, pelo qual a APS é considerada o nível basilar e porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), e que tem a responsabilidade de absorver 85% dos serviços (Brasil, 1988; Matta *et al.*, 2007; CONASS, 2019), observou-se que apenas um dos participantes possuía plano de saúde privado, o que demonstra um alcance importante do SUS em relação à população estudada.

No tocante à consulta psiquiátrica ou psicológica, oito (72,72%) afirmaram nunca ter procurado esse tipo de atendimento, enquanto três (27,27%) declararam que já foram atendidos por psicólogos, porém, não obtiveram nenhum diagnóstico. A consulta psicológica é um recurso primordial para a promoção da saúde mental e bem-estar. No entanto, muitas pessoas ainda resistem em procurar esse serviço devido a estigmas e preconceitos associados à saúde mental (Lemos; Lhullier, 2020).

A Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), destaca a importância da atenção primária na promoção da saúde e prevenção de doenças (Brasil, 2017). Nesse contexto, a psicologia desempenha um papel crucial na atenção primária, visto que contribui para a melhoria da saúde mental e qualidade de vida da população. A psicologia, como parte de equipe multidisciplinar na atenção primária, é essencial para abordar as necessidades psicossociais dos indivíduos e famílias, já que promove a prevenção e o tratamento de problemas de saúde mental (Almeida *et al.*, 2022).

Assim, a importância da consulta psicológica é inegável, pois ela oferece um espaço seguro e confidencial para que as pessoas possam discutir seus problemas e encontrar possíveis soluções. Além disso, a consulta psicológica pode ajudar a prevenir problemas mais graves, como depressão e ansiedade, e melhorar a qualidade de vida (Amorim; Almeida Lopes, 2022).

No entanto, a resistência da população em procurar ajuda psicológica é um desafio significativo. Muitas pessoas acreditam que procurar ajuda psicológica é um sinal de fraqueza ou que apenas pessoas "loucas" precisam de terapia. Adicionalmente, a falta de informação e o estigma associado à saúde mental podem impedir que as pessoas busquem ajuda (SER, 2024).

A consulta psicológica precisa ser compreendida como um recurso essencial para promover saúde e bem-estar, e não como um indicativo de fragilidade. Ao valorizá-la como uma alternativa legítima e necessária para o cuidado com a saúde mental, torna-se possível diminuir a resistência da população e contribuir para a melhoria da qualidade de vida (Santos *et al.*, 2025).

Todavia, outros fatores que dificultam esse tipo de atendimento são a escassez de psicólogos no SUS, a falta de formação adequada e educação continuada dos profissionais, a desarticulação da rede de atenção psicossocial, aliada à precariedade da comunicação entre os diferentes níveis; esses fatores comprometem a continuidade e integralidade dos cuidados em saúde mental. As demandas sociais complexas nas comunidades exigem abordagens integradas, mas as limitações institucionais e a sobrecarga de trabalho dificultam isso. Para superar esses desafios, são necessárias ações coordenadas, com investimentos em capacitação profissional, fortalecimento da gestão local, articulação eficaz da rede e engajamento da comunidade para reduzir o estigma (Macêdo Neto; Macedo, 2025).

Quanto ao uso de medicamentos psiquiátricos, nove (81,81%) referiram que nunca os usaram, o que demonstra uma baixa prevalência de uso dessas substâncias nesse grupo. Por outro lado, um participante (9,09%) informou que havia feito uso de sertralina, um medicamento antidepressivo, após o tratamento de infecção por Covid-19, mas cessou o uso do medicamento após um período de tratamento; e um (9,09%) referiu que estava fazendo uso de clonazepam por insônia adquirida após a infecção por Covid-19.

Apesar do reduzido uso de medicamentos psiquiátricos, observado neste estudo, outras pesquisas demonstraram um aumento significativo no uso dessas drogas mentais, como antidepressivos e ansiolíticos, durante e após a pandemia, tanto em jovens quanto entre idosos (Barros; Silva, 2023; Araújo, 2023; Alcoforado; Mendonça, 2025).

Esse aumento pode estar intrinsecamente ligado ao incremento de ansiedade, estresse e incerteza experimentados durante o período pandêmico, bem como a um maior alcance e disponibilidade dos serviços de saúde mental, à ampliação de modalidades, como telessaúde, clínicas especializadas e iniciativas comunitárias de saúde mental (Souza *et al.*, 2024; Green-Blatt Kimron *et al.*, 2023).

Não obstante, a banalização da prescrição de psicofármacos é um problema crescente na atualidade, pois, na maioria das vezes, esses medicamentos são prescritos de forma indiscriminada e sem um diagnóstico preciso, levando à medicalização excessiva da saúde mental. Isso pode resultar em dependência, efeitos colaterais graves e falta de abordagem terapêutica integral e eficaz. Além disso, a pressão da indústria farmacêutica e a falta de acesso a tratamentos alternativos, como terapia cognitivo-comportamental, podem contribuir para essa tendência (Ferrazza *et al.*, 2010).

Da sistematização e análise, emergiram as temáticas: Repercussões mentais e psicológicas/emocionais da Covid-19 na vida dos idosos; Impactos físicos da Covid-19 na vida dos idosos; e o papel da espiritualidade como fonte de apoio emocional para idosos durante a pandemia de Covid-19.

Repercussões Mentais e Psicológicas/Emocionais da Covid-19 na Vida dos Idosos

Durante as entrevistas, alguns dos idosos expressaram ter experienciado uma variedade de emoções em relação ao isolamento social da pandemia da Covid-19, predominantemente negativas, incluindo medo, tristeza, preocupação, sofrimento, isolamento e desamparo. Esses sentimentos são ilustrados nos trechos das entrevistas, apresentados a seguir.

[...] isolamento social com certeza nos afetou bastante, nossa! nem pra igreja e nem pra lugar nenhum a gente podia. Fechava o portão e ficava a família. Não podia receber as pessoas. É isso, não foi fácil (S3).

[...] afetou muito, porque a gente não podia sair para parte nenhuma, tinha medo de pegar covid, mas mesmo assim a gente pegou covid (S4).

[...] Eu fiquei em torno de quinze e vinte dias sem poder sair de casa e sem poder conversar, então isso sim, isso me afetou. Porque eu não podia conversar com as pessoas, e as pessoas que chegavam no portão, eu só respondia pela janela. Isso me afetou bastante (S5).

[...] a gente era acostumada a ser livre e, de repente, se ver fechada, complicado, parece que você está numa prisão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é complicado daí (S8).

Os relatos acima ilustram que o isolamento social, durante a pandemia de Covid-19, teve um impacto negativo na vida dessas pessoas. Muitos destacam a sensação de perda de liberdade e a restrição à vida social, que antes era uma parte natural do dia a dia. A impossibilidade de sair de casa, receber visitas ou participar de atividades religiosas e sociais gerou sentimentos de clausura e prisão.

Além disso, o isolamento social afetou a saúde mental e emocional, com relatos de falta de interação social e necessidade de se comunicar apenas por meios limitados. A solidão e a falta de contato físico podem ter contribuído para o aumento do estresse, ansiedade e depressão.

É curioso observar que, embora o isolamento social tenha sido uma medida para proteger a saúde das pessoas, ele afetou significativamente a saúde mental e emocional. O medo e a ansiedade relacionados à Covid-19 foram fatores importantes, já que, mesmo com precauções, a doença ainda podia ser contraída, o que aumentava o estresse e a incerteza (Pecoits *et al.*, 2021; Vieira *et al.*, 2025).

O isolamento social pode ter consequências significativas para a saúde e o bem-estar de indivíduos, incluindo efeitos negativos na saúde mental, como

demência, sentimentos de solidão, ansiedade, depressão, estresse e distúrbios do sono, assim como agravamento de condições, como hipertensão e diabetes. Além disso, pode ocasionar mudanças prejudiciais no estilo de vida, como redução da atividade física e hábitos alimentares pouco saudáveis (Freitas *et al.*, 2022; Zaninotto *et al.*, 2022).

Em consonância com esses fatos, uma revisão integrativa de 27 estudos revelou que a pandemia de Covid-19 pode ter desencadeado vários problemas de saúde mental em idosos, incluindo ansiedade, depressão, solidão, estresse, medo, pânico, tristeza, pensamentos suicidas e insônia (Pedreira *et al.*, 2022).

Por outro lado, outros participantes referiram sentir indiferença em relação ao isolamento social, especialmente, aqueles que mantiveram suas ocupações e que saíam de casa.

[...] a gente já vem num ritmo que só entre a família, não tem aquela vida pública, cheia de extravagância, então não mudou muito, era de casa para trabalho e de trabalho para casa, então não mudou muito (S9).

[...] não, não senti falta, porque eu sabia que precisava ficar em casa. Quando eu saía, saía bem-preparada, saía de máscara, saía com meus óculos, saía com minhas coisas de passar na mão, é assim. Mas não fiquei em casa. Não achei tão ruim., porque a gente tem que fazer o que é preciso fazer, evitar de ficar pior (S11).

[...] não, não sofri muito com o isolamento social. Aquele tempo fiquei em casa, tenho um trabalho aqui na frente, e eu não parei, continuei trabalhando. Então não fiquei isolado (S6).

[...] O isolamento social não me afetou em nada, eu saía, eu ia no mercado tudo (S2).

As falas observadas, aqui, indicam que esses idosos tiveram um impacto reduzido em relação ao isolamento social, durante a pandemia da Covid-19, possivelmente, devido a fatores, como o estilo de vida pré-pandemia, que já era mais restrito e centrado na família. Além disso, alguns idosos parecem ter adotado uma postura de aceitação e adaptação à situação, priorizando a segurança e a prevenção.

Outro fator importante foi a manutenção de atividades e rotinas, como o trabalho, que ajudou a estabelecer a sensação de normalidade e evitar o isolamento. Além disso, alguns idosos parecem ter mantido uma certa independência e autonomia, continuando a realizar atividades essenciais, como ir ao mercado.

Esses relatos sugerem que a resiliência e a capacidade de adaptação podem ter desempenhado um papel importante na forma como esses idosos lidaram com o isolamento social durante a pandemia. Além disso, o apoio da família e a manutenção de atividades significativas também podem ter contribuído para minimizar o impacto do isolamento social (Jeste *et al.*, 2021; Vicente *et al.*, 2023; Silva; Mariotti; Bridi, 2020).

Em relação ao alcance da Covid-19, quase a totalidade dos participantes informou que algum familiar ou vizinho foi afetado pela doença; apenas um referiu não ter conhecido ninguém além de si mesmo que tenha sido vítima da Covid-19.

[...] aqui muito, muitos pegaram, meu filho também pegou (S11).

[...] olha, o que posso te dizer rapaz, aqui em casa todo mundo teve, meu filho teve, minha esposa teve, parece que uma das minhas filhas também teve, mas foi aliviando, e fizeram tratamento em casa mesmo (S10).

[...] todos meus filhos pegaram. Todos eles pegaram (S9).

[...] conheci um ex-colega de trabalho, que também teve covid, foi intubado, e depois extubado, novamente intubado, e faleceu (S5).

[...] meu marido pegou, meu filho pegou e minhas duas filhas também pegaram, só não pegou uma das minhas filhas porque não teve contato comigo (S7).

[...] na verdade meus filhos. Meu marido nunca pegou, que vivia junto na cama e no café e no almoço nunca pegou, agora meus filhos bastante deles pegaram (S3).

[...] com covid sim, que conheço assim, tanto que tiveram foram poucos, e não ficaram com problema. E as pessoas aqui perto que pegaram e com poucos dias já estavam bem (S6).

[...] os vizinhos aqui do lado também pegaram, mas ninguém foi para hospital, ficaram em casa. Meu marido também pegou covid, mas não foi internado (S4).

[...] conheci esse que morreu lá, era meu vizinho né, ele foi internado no mesmo dia lá e durou só dezenove dias no hospital e faleceu (S2).

[...] eu conheço uma pessoa que, foi internado comigo em Nova Aurora (S1).

Os relatos dos idosos mostram que a Covid-19 teve um alcance amplo em suas comunidades, afetando muitas pessoas, incluindo familiares e vizinhos. Muitos informaram que vários membros da família contraíram a doença. Outros relataram que

a doença foi mais leve, em alguns casos, com tratamento em casa, enquanto alguns mencionam casos mais graves, com internações e até mesmo óbitos.

Pode-se notar que, para alguns idosos, a doença não foi tão grave em sua comunidade, com poucos casos e poucas hospitalizações. Embora a doença tenha sido mais leve, em alguns casos, outros enfrentaram situações mais graves e até mesmo óbitos.

O conceito de pandemia está, diretamente, relacionado ao alcance de uma determinada doença; esse conceito carrega uma trajetória histórica extensa, porém, ainda carece de uma definição consolidada em diversos textos médicos, estando sua compreensão em constante evolução. Contudo, existem aspectos fundamentais que caracterizam uma pandemia, tais como: abrangência geográfica ampla, propagação da doença, caráter inovador, severidade, taxas elevadas de incidência e natureza explosiva, baixa imunidade na população, além de sua capacidade infecciosa e contagiosa, elementos que contribuem para a compreensão do fenômeno das pandemias (Qiu *et al.*, 2017).

Nesse sentido, percebe-se, neste estudo, que, além dos participantes, pessoas de seu convívio foram alcançadas, mostrando a amplitude da doença. A pandemia da Covid-19 ensejou um impacto importante na vida da população mundial. Até o dia 02 de maio de 2023, os números globais da pandemia eram de 764.474.387 casos confirmados e 6.915.286 óbitos registrados em todo o mundo. No Brasil, os dados mostravam um impacto significativo, com 37.449.418 casos confirmados e 701.494 óbitos, o que demonstra a extensão do desafio sanitário enfrentado pelo país e globalmente (Brasil, 2023; WHO, 2023a).

No estado do Paraná, os dados relativos à Covid-19, até 02 de maio de 2023, apresentavam um cenário considerável: 2.923.000 casos confirmados e 46.073 óbitos. Esses números evidenciam o impacto substancial da pandemia na população paranaense, refletindo os esforços e desafios enfrentados pelas autoridades de saúde locais no manejo da crise sanitária naquele período (Brasil, 2023).

Considerando que, dos onze participantes deste estudo, dez afirmaram conhecer alguém que foi vítima do vírus, pode-se inferir a probabilidade de que os números reais da Covid-19, tanto globalmente quanto no Brasil e no Paraná, possam ter sido subestimados devido à baixa notificação de casos, especialmente, considerando fatores diversos, como a subnotificação de casos leves ou assintomáticos, limitações nos sistemas de vigilância epidemiológica e possíveis

variações na capacidade de teste e registro em diferentes regiões. Essa subnotificação pode ter impactado a compreensão plena do alcance da pandemia e influenciado as análises sobre a morbidade e mortalidade associadas à doença (Prado *et al.*, 2020).

Não obstante, fatores diversos, a exemplo da escassez de kits diagnósticos e estrutura apropriada, dificuldades relacionadas aos encargos financeiros envolvidos, além de aspectos culturais e políticos, podem ter sido obstáculos à identificação ou à adesão ao rastreio do vírus, culminando em subnotificações (Lau *et al.*, 2020).

Em relação à percepção ou experiências que os idosos tiveram com a infecção por Covid-19, eles destacaram a gravidade da doença e o medo associado a ela, abrangendo, desde momentos de grande vulnerabilidade, até aspectos de resiliência e crescimento pessoal.

[...] sei lá filho, não quero pegar nunca mais, porque a gente sabe que é uma coisa triste, é uma coisa que mata mesmo, a experiência que a gente teve não foi boa, mesmo que a gente não morreu no caso, até hoje a gente tem medo dela, que acredito que ela não foi embora de tudo (S3).

[...] quando me pegou isso aí, eu era carregado no colo como se fosse uma criança, eu lembro ainda, eu já estava voltando normal, eu era pegado assim como se fosse uma criança assim, de tão magro que fiquei, afetou bastante quando eu peguei essa doença (S1).

[...] não foi boa, porque a gente viu dos outros e falar dos outros e não tinha noção do que era, quando aconteceu com a gente que a gente foi entender mais ou menos, porque, poxa vida, não só as pessoas sabem falar é fácil, agora passar pelo problema aí é diferente (S6).

[...] foi bem ruim (riso), a experiência não foi fácil (S8).

[...] porque a gente não sabe de onde veio isso, eu não sei de onde que peguei, mas quando eu fui fazer o teste eu desabei daí, daí fui pro hospital. Foi feio o negócio, meu Deus do céu, foi ruim meu Deus, eu não puxava fôlego, sei que me levaram lá e logo depois me intubaram, porque não lembro mais de nada quando eu cheguei (S4).

[...] então se fosse alguma coisa que a gente pudesse resolver nunca queria que ter isso aí acontecido com a gente. Então é por Deus, e tem que conformar, penso assim (S10).

[...] mudou minha vida, que eu vi que poderia agir melhor com meus semelhantes, ser uma pessoa melhor (S5).

[...] boa não foi não, mas pra mim, ruim tanto também não, porque eu consegui vencer também, eu fiz tudo que era para fazer, o que era

para respeitar eu respeitei, então para mim, tudo passou. E sempre é assim (S11).

Alguns idosos referiram que a doença os deixou extremamente debilitados e dependentes dos outros para realizar as suas necessidades diárias. Outros relataram que a experiência foi difícil de lidar, revelando a falta de percepção da gravidade no início da pandemia, porém, quando foram atingidos, foi o momento em que experienciaram a severidade da doença. Isso pode indicar que, apesar do constante alerta sobre a complexidade do vírus da Covid-19, durante a pandemia, algumas pessoas não se atentaram até terem sido afligidos.

Observaram-se, também, relatos de que a doença propiciou mudanças na perspectiva de vida, gerando alterações de comportamento em relação ao modo de tratar os outros, ser uma pessoa melhor. Além disso, outros relatam que a experiência foi difícil, mas se consideram vencedores por ter conseguido superá-la.

Essas experiências foram marcadas por desafios e mudanças significativas em suas vidas. No entanto, muitos relatam que a experiência os tornou mais fortes e resilientes, visto que aprenderam a valorizar a vida e a cuidar melhor de si e dos outros.

Um estudo focado na percepção de idosos, em relação à Covid-19, revelou que os idosos, frequentemente, expressavam sentimentos de medo, especialmente, o temor de perder entes queridos, além de destacarem experiências nocivas de isolamento social. Contudo, o período pandêmico propiciou processos de resiliência, aprendizado e reflexão (Marrocos *et al.*, 2021).

É fundamental considerar as preocupações expressas pelos idosos, como medo, isolamento social e estresse, ao elaborar políticas públicas e cuidados à saúde. Esses fatores são cruciais e podem desencadear problemas de saúde mental significativos, incluindo depressão, ansiedade, síndrome do pânico e insônia, dentre outros (Marinho; Oliveira; Carneiro, 2023).

Outrossim, foram revelados relatos de uma transformação positiva entre alguns dos idosos em sua visão de vida e emocional, após a experiência com a doença, com manifestação de estabilidade emocional.

[...] para te falar verdade, antes de pegar essa doença, como eu falei, eu bebia e fumava, era uma diversão pra mim, nossa, e levantava e fumava e beleza, e depois que eu peguei, e eu analisei, era uma porcaria, por que não parei antes aquele lá? eu achei que estava

abafando. Hoje me sinto mais feliz, mais tranquilo do que antes. Se eu tivesse parado antes, tinha que pegar dessa doença para eu parar. Hoje me sinto melhor do que antes. Eu vou lá na mercearia fazer minhas comprinhas. Eu vou a que não tem bebum ali no mercado. Mas lá na mercearia que eu vou tem os bebuns lá, que toma e fuma, até saio de perto. Aquele cheiro hoje, até o cheiro me incomoda (S1).

[...] feliz, penso assim, por estar viva, por ter passado e ficado viva, porque se eu tivesse morrido era complicado, mas graças a Deus estou viva (S8).

[...] mudou a resignação, a gente se torna mais resignado e tratar melhor as pessoas, assimila melhor os problemas que tem e aquela irritação às vezes com o ser humano, hoje praticamente isso sumiu. Depois da covid, me acho muito mais feliz, por ter sobrevivido, e por tentar dar mais alguma contribuição de alguma forma, palavra, gesto, qualquer coisa com meu semelhante (S5).

Alguns dos idosos evidenciaram que a doença os fez reavaliar seus hábitos e estilo de vida, levando-os a abandonar vícios e se sentir mais felizes e tranquilos. A experiência da doença ocasionou uma nova perspectiva sobre a importância da vida e da saúde. Muitos expressam gratidão por ter sobrevivido e se sentem felizes por estar vivos, reconhecendo a importância de valorizar cada momento da vida.

Além disso, a Covid-19 provocou mudanças na forma como as pessoas lidam com os problemas e as relações humanas. Alguns revelam que a doença os tornou mais pacientes e empáticos, com uma maior capacidade de lidar com os desafios e tratar as pessoas com mais compreensão.

A doença efetivou a reavaliação das prioridades e a busca por uma vida mais saudável e significativa, além de buscar valorizar coisas mais simples da vida e contribuir para o bem-estar dos outros.

Percebe-se, nesses relatos, que a Covid-19 desencadeou uma transformação positiva na vida desses idosos, fazendo-os valorizar a vida, a saúde e as relações humanas, bem como buscar uma vida mais plena e significativa.

O estudo do Liang *et al.* (2025) observou que indivíduos infectados com Covid-19 experimentaram Crescimento Pós-Traumático; *Posttraumatic Growth* (PTG) em inglês, subsequente à doença, porém, os níveis de PTG foram relativamente baixos, possivelmente, influenciados pela postura governamental de controle e pelo contexto de trauma compartilhado pela coletividade, fatores que podem ter diminuído a intensidade da exposição traumática percebida.

Em relação a efeitos da Covid-19 no aspecto emocional, alguns revelaram sentimentos de medo, ansiedade e vulnerabilidade, refletindo o temor de contrair a doença novamente, a incerteza sobre as consequências para a saúde e o medo da morte.

[...] ah, afetou bastante emocional, porque qualquer coisa quero chorar (choro), não é fácil, meu Deus do céu, só a gente que sabe, é muito difícil (choro) (S4).

[...] antes eu era uma pessoa tranquila assim sabe, mas agora eu tenho mais medo, tenho mais medo porque penso que se eu pegar de novo, eu sei que não me salvo, porque os pulmões, do jeito que ficaram, se nós pegamos covid de novo, é muito difícil, porque o médico mesmo falou para mim (S7).

[...] com certeza a gente fica com medo. Porque estava morrendo gente toda hora (S6).

[...] eu tive muito medo, foi bem complicado no hospital, foi bem complicado. Lá parecia que eu via os dois lados, lado da vida e outro lado também (S8).

[...] ah eu tinha medo de pegar sim, meu Deus do céu, eu tinha muito medo, eu orava bastante para Deus abençoar que a gente não pegasse (S3).

[...] quem não tem [medo], pegar uma praga dessa que ninguém conhece e não sabe de onde veio (S9).

[...] mas tive sim medo de morrer, a gente tem medo, tem medo sim, mas graças a Deus, pelos sintomas que eu tive, hoje me considero curado (S10).

Os relatos revelam que a experiência da doença foi traumática, e que, ainda, sentem os efeitos emocionais. A doença ocasionou medo intenso, especialmente, em relação à possibilidade de contrair novamente; a experiência no hospital foi assustadora e o medo de morrer foi uma realidade para muitos.

Os relatos sugerem que a Covid-19 teve um impacto deletério na saúde emocional/psicológica, deixando sentimentos de medo, ansiedade e vulnerabilidade. É importante que esses sentimentos sejam reconhecidos e abordados para garantir a saúde mental e o bem-estar.

Estudos recentes têm demonstrado que a pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo na saúde mental e emocional de idosos, revelando uma gama de efeitos psicológicos adversos que afetaram essa população de maneira particular (Narciso *et al.*, 2024; Gugliotti *et al.*, 2024). Vale ressaltar que existe associação direta

entre o medo e manifestações emocionais de ansiedade e depressão, além de uma ligação com a percepção de risco e a idade mais avançada. Esses elementos devem ser considerados na elaboração de estratégias de intervenção voltadas para mitigar os medos associados à Covid-19 na população (Han; Mahendra, 2021; Holeva *et al.*, 2022).

A ansiedade e depressão configuram-se como um fenômeno complexo e abrangente que impacta significativamente os idosos, influenciando aspectos físicos, psicológicos e emocionais de sua saúde. A experiência da pandemia de Covid-19 evidenciou a necessidade crítica de considerar e tratar a ansiedade nessa faixa etária, tanto pelo impacto imediato no bem-estar quanto pelas possíveis repercussões duradouras. Diante da contínua investigação sobre as nuances da ansiedade, torna-se essencial criar estratégias específicas de intervenção e estruturas de suporte que atendam às particularidades dos idosos no enfrentamento e controle dessa condição (Cenedesi Júnior *et al.*, 2023).

Paralelamente, uma parcela significativa dos idosos relatou estabilidade emocional, indicando ausência de alterações marcantes em seu bem-estar psicológico após a infecção.

[...] isso aí não mudou não, sabe, está normal, meu estado emocional continua o mesmo (6).

[...] não me sinto mais feliz ou mais triste, pra mim tá tudo normal (S7).

[...] antes da covid, eu sentia bem, e agora que eu me tratei, eu consegui a se curar, eu sinto bem também (S10).

[...] antes estava bom, e depois dela também estou bem (S11).

[...] também não mudou nada (S9).

Baseado nos relatos, pode-se inferir que a estabilidade emocional parece ter sido mantida pelos idosos durante a pandemia de Covid-19. As falas sugerem que a doença não teve um impacto significativo no aspecto emocional desse grupo. Eles disseram que seu estado emocional continua o mesmo, e que se sentem "normais," sem a percepção de nenhuma diferença em relação ao período antes da pandemia.

Isso pode indicar que esses idosos têm uma boa capacidade de lidar com as adversidades e manter a estabilidade emocional, mesmo diante de desafios, como a pandemia. É importante notar que a estabilidade emocional é um aspecto importante

da saúde mental e pode ser influenciada por fatores variados, como apoio social, hábitos saudáveis e resiliência.

Esses padrões sugerem que a resposta emocional à experiência com a Covid-19 é heterogênea entre os idosos, refletindo diferenças individuais na resiliência, percepção da doença e processos de *coping*. A diversidade de percepções destaca a complexidade do impacto psicológico da pandemia nessa população, apontando para a importância de abordagens personalizadas no apoio ao bem-estar emocional dos idosos (Karmann *et al.*, 2023).

Em relação ao funcionamento de memória desses idosos, após terem sobrevivido à Covid-19, revelou-se uma preocupação significativa com a saúde mental, especialmente, em relação ao esquecimento e à perda de memória. Um número importante dos idosos revelam que ficaram mais esquecidos, com dificuldade de lembrar de coisas que, antes, eram fáceis de recordar. Além do esquecimento, outros sintomas mencionados incluem dor de cabeça e ansiedade.

[...] é aquele que te falei antes, esquecimento. Eu era esquecida, mas agora fiquei mais esquecida um pouco. Fiquei mais esquecida mesmo, é só isso aí (S2).

[...] agora está bem mais ou menos minha memória assim, esquecimento bastante, não lembro das coisas assim, daí tem que parar e pensar, daí lembra de novo, daí é assim, esquecimento, fraqueza nas pernas e me dá muita dor de cabeça, por isso estou tomando esses remédios agora. Me deu ansiedade e muita enxaqueca me dá, daí eu tenho que tomar remédio se não, não passa, até esse dia eu fui internada lá com dor de cabeça e ansiedade (S4).

[...] memória, esquecimento, esquecimento foi o principal, que coisas que eu sempre lembrava, de repente deu aquele apagão, e eu fiquei esquecido de muitas coisas (S5).

[...] está mais fraca, bem fraca [a memória], porque a gente às vezes vai fazer uma coisa, vai buscar e tu tem que voltar para ver o que ia buscar (riso), mais esquecida ishi nossa, até ontem estava bem esquecida (S8).

[...] pois é, é o que eu digo, parece que tem dia que a memória não está boa, parece que está meia cansada e meia fracassada. Esquecimento, isso aí vem (S11).

Os idosos referiram que, após a infecção pela Covid-19, perceberam alterações na memória, com episódios de esquecimento e dificuldade para lembrar de coisas

simples. Mencionaram que precisam se esforçar para lembrar de coisas que, antes, eram fáceis de lembrar.

Além do esquecimento, alguns idosos mencionam problemas de ansiedade, dor de cabeça e cansaço. Esses sintomas podem estar relacionados à perda de memória e à dificuldade de concentração, os quais podem impactar a qualidade de vida dos idosos (Carvalho; Silva; Rocha-Filho, 2024)

É importante que esses problemas sejam abordados e tratados com apoio médico e psicológico, para ajudar os idosos a lidar com as consequências da Covid-19, além de melhorar a sua independência e autoestima (Prates *et al.*, 2024).

Estudos revelam que a Covid-19 pode causar problemas neurais significativos, incluindo dificuldade de concentração, perda de memória, confusão mental e falta de clareza, que pode ocorrer na fase aguda da doença e permanecer no pós-tratamento. Esses sintomas podem persistir por semanas ou até meses após a recuperação da doença, afetando a qualidade de vida dos pacientes (Krishnan *et al.*, 2022; Joseph, 2022; Fernández-De-Las-Peñas *et al.*, 2023).

Problemas neurais têm impacto significativo na qualidade de vida das pessoas, o que torna difícil realizar tarefas diárias e manter a independência (Carvalho; Silva; Rocha-Filho, 2024). É fundamental que os profissionais de saúde estejam cientes desses sintomas, a fim de oferecer apoio e tratamento adequado, incluindo terapias cognitivas, exercícios mentais e apoio emocional, para ajudar os pacientes a gerenciar os efeitos da doença na sua saúde mental e cognitiva (Souza *et al.*, 2022).

Em contrapartida a esses relatos, uma parte importante dos idosos referiu que tem mantido o funcionamento da sua memória sem nenhuma alteração.

[...] não, não. na minha cabeça não afetou nada. Graças a Deus está normal mesmo como eu era antes, como sempre foi (S1).

[...] não sinto nada, nem esquecimento, graças a Deus. Então, pode ser que ficou, mas não está dando pra ver não, e já faz cinco anos né, foi em 2020. Eu acho que não ficou nada. Minha memória está tranquila (S3).

[...] não. inclusive o médico falou pra ela lá que eu ia ficar com muitos problemas, mas graças a Deus não tive nem um ponto mesmo, fiquei cem por cento. fiquei bem mesmo, estou até hoje, falaram que eu não ia lembrar das coisas, mas não (S6).

[...] não, a minha memória está boa, boa, boa (S7).

[...] minha memória é boa, eu por enquanto não sinto nada assim de fraqueza de memória. Guardo as coisas bem. Decido coisas uma da outra, assim, mesmo na idade que tenho, mas graças a Deus minha memória é boa (10).

[...] não, não afetou nada, não houve nada, continuo normal, eu que mantenho minha casa, eu que mantenho minhas contas, eu que mexo com tudo minhas contas bancárias que pago minhas contas, não dependo de ninguém, entende, a única coisa que depende de gente é, por exemplo, quando quero sair e eu preciso de alguém para dirigir o carro para mim (S9).

Esses idosos relataram que a infecção pela Covid-19 não alterou a memória, sendo que continuam a ter uma boa capacidade de lembrar de coisas e tomar decisões relativas às suas vidas.

Alguns expuseram que os médicos alertaram sobre possíveis problemas de memória, após a infecção, mas que, felizmente, isso não ocorreu. Nesse grupo, os relatos mostraram que a Covid-19 não teve um impacto negativo na sua memória, de maneira que continuam a ser independentes e capazes de gerenciar suas vidas diárias sem problemas.

A infecção por Covid-19 pode ter consequências diversas e amplas para a saúde humana, afetando tanto o bem-estar físico quanto o mental. Podem surgir desde sintomas iniciais, como febre e tosse, até complicações mais graves, a saber, cansaço persistente, lesões em órgãos vitais, dificuldades cognitivas e transtornos mentais. A Covid-19 pode impactar as pessoas de maneiras muito diferentes. A gravidade e duração desses efeitos dependem de vários fatores, incluindo a idade do indivíduo, condições de saúde pré-existentes e o tipo específico de variante do vírus. Para alguns, os sintomas podem se estender por um longo período, configurando o que é conhecido como "Covid longa.". E, para outros, pode ocorrer de forma branda ou até assintomática (Porto *et al.*, 2021; Rodriguez *et al.*, 2022; Statsenko *et al.*, 2022; Henneghan *et al.*, 2022; Ravindra *et al.*, 2022).

Impactos Físicos da Covid-19 na Vida dos Idosos

A infecção por Covid-19 pode ter impactado, negativamente, a saúde dos participantes, afetando não apenas a saúde mental, mas a saúde física e a qualidade de vida. Muitos relataram sequelas graves, como perda de mobilidade, fraqueza

muscular, dormência nos pés e problemas de audição, que afetaram sua capacidade de realizar atividades cotidianas.

[...] afetou, afetou sim. Fiquei com muito medo. Quando eu saí do hospital, eu não caminhava, eu não mexia uma mão, nem os pés, nada. Eu fui catada no colo e trazida para casa. E eu tinha medo de ficar no quarto sozinha, eu tinha muito medo, e agora os pulmões da gente ficaram muito fracos, tanto os meus como dos meu marido. Qualquer friozinho tem que ficar agasalhado porque corre risco de pegar pneumonia (S7).

[...] a única coisa que afetou foi a saúde, me tirou o movimento da perna, a covid atacou a minha coluna, e daí perdi os movimentos da perna com isso aí (S9).

[...] Na verdade, afetou mesmo, perdi bastante peso. Fiquei bem, bem magro, que isso ali que falei que deu no ouvido, que perdi audição, deu sequela. Não perdi totalmente a audição, mas ela diminuiu bastante, desse lado (ouvido esquerdo) (S1).

[...] antes eu podia morar sozinha e depois eu não posso mais. Eu tive que morar com minha filha, mas é que, acontece assim, às vezes a gente perde a memória e não ficou assim legal como era, ficou diferente, bem diferente (S8).

[...] só que aí, fiquei com uma dormência nos pés, e até hoje não acabou. Fiquei com aquelas dormências nos pés, e meus pés incham muito, e assim vai ficando (10).

[...] é uma espécie de fraqueza mesmo, muscular, muscular afetou também (S5).

[...] foi difícil, meu Deus do céu, me tratavam tudo, e eu não conseguia comer, sozinha não conseguia caminhar, nem me virar na cama nada, era tudo eles que tinha que fazer para mim, eu cheguei em casa assim, não fazia nada, eu tinha que aprender a fazer tudo de novo, foi difícil, meu Deus do céu (S4).

Nota-se que esses participantes referiram, além de impactos mentais, também sequelas físicas importantes, ocorridas após infecção por Covid-19, como perda de mobilidade, dor crônica, problemas respiratórios e até mesmo perda de audição.

Além disso, a doença também afetou a independência e a autonomia de alguns, que precisaram se mudar para casas de familiares a fim de receber cuidados; esses indivíduos expressaram, ainda, uma experiência marcada por medo e ansiedade. A Covid-19 também provocou mudanças significativas para a qualidade de vida dessas pessoas, com relatos de perda de peso, dormência nos pés e fraqueza muscular.

A internação prolongada em UTI pode ter provocado fraquezas musculares relatadas por esses idosos, resultado da imobilidade prolongada e do uso de medicamentos que afetam a musculatura. Um deles apresentou paraplegia, após infecção pelo vírus, podendo ter relação com neurotropismo do microrganismo. Além disso, problemas de audição foram relatados, demonstrando consequências variadas do vírus. Foram evidenciados também problemas pulmonares que podem ter relação direta com a infecção pela Covid-19, por ter, como alvo principal, os pulmões, e/ou a consequência da ventilação mecânica prolongada, que incidem na redução da capacidade respiratória e na necessidade de oxigênio suplementar por mais tempo. Isso pode aumentar o risco de complicações respiratórias futuras e prolongar o tempo de recuperação.

A infecção por Covid-19 pode prejudicar a saúde física de várias maneiras, causando problemas respiratórios, cardíacos e musculares. O isolamento social, na pandemia, assim como a internação hospitalar prolongada podem contribuir para agravar esses efeitos (Pierre *et al.*, 2025; Araújo *et al.*, 2022; Huang *et al.*, 2020).

Percebe-se que a Covid-19 pode ter desencadeado impactos negativos para a vida desse público, afetando não apenas a saúde mental, mas também a saúde física e a independência. A fraqueza muscular e as complicações da medula espinhal podem ter um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas, tornando difícil realizar atividades diárias e reduzindo a independência. É fundamental que sejam oferecidos apoio e cuidados adequados para ajudar os idosos a lidar com as sequelas da doença e melhorar sua qualidade de vida (Huang *et al.*, 2020; Garrigues *et al.*, 2020; Lopes; Souza; Barbosa, 2024).

Além disso, quando indagados em relação à sua capacidade de dormir, constatou-se que a Covid-19 teve um impacto adverso no sono de uma parcela dos idosos.

[...] antes eu dormia bem, daí quando eu cheguei em casa que me deu alta, não dormia de noite, não dormia de dia, daí veio o médico e me receitou remédio, daí eles me dava remédio, daí eu dormia, isso foi bem bastante tempo, só que agora daí aquele eu parei, eu estou tomando esse aqui agora, que é mais fraco, mas eu não dormia (S4).

[...] depois que passei covid, eu tomo dez gotinhas de remédio que foi indicado no posto para poder dormir, agora não lembro o nome do remédio. Sei que tomo dez gotinhas para dormir, senão, não durmo. Antes da covid eu não tomava, mas depois da covid tenho que tomar para poder dormir (S7).

[...] a qualidade mudou, eu tinha um sono melhor, mais relaxante antes da covid, depois da covid, eu tenho que induzir alguma coisa, ou fisicamente, cansando, alguma coisa para ter um sono mais relaxante depois da covid (...) mudou, eu apelo pela homeopatia, alguns chazinhos, chazinhos que é relaxante tal, uma erva que a gente conhece, eu sempre tomo alguma coisa assim (S5).

[...] atrapalhou bastante, não durmo de imediato, a gente não dorme. (...) sim, eu dormia bem melhor (S8).

[...] agora tá melhorando. Estava ruim para dormir. Até que estou dormindo bem. Às vezes tomo sertralina, mas faz dias que não tomo mais. Estou conseguindo dormir (S2).

A Covid-19 pode ter impactado negativamente o sono de alguns dos participantes. Houve relatos de que, após terem sido atingidos pela doença, a qualidade do sono diminuiu, com dificuldade de pegar no sono, ou ter um sono restaurador, de maneira que, por vezes, precisam tomar medicamentos ou recorrer aos métodos naturais, como chazinhos e ervas relaxantes para poderem dormir.

A maioria concorda que a Covid-19 afetou, negativamente, o sono, tornando-o mais difícil e menos reparador. Eles revelaram que contraíram problemas de sono com a infecção por Covid-19, sendo que, antes da doença, dormiam melhor.

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais (DSM-5), o Transtorno de Insônia é caracterizado por uma qualidade ou quantidade inadequada de sono, manifestada por dificuldade em adormecer, permanecer dormindo ou retornar ao sono após despertar, apesar de haver oportunidades adequadas para dormir, o que resulta em comprometimento significativo durante o dia ou estresse emocional relevante (National Library of Medicine, 2016).

A pandemia da Covid-19 afetou, grandemente, a qualidade do sono e influenciou a prática clínica relacionada ao sono. No contexto da Covid-19, aumentou a incidência de problemas de insônia, sono fragmentado e pesadelos, além de ansiedade e depressão na população em geral, fenômeno, por vezes, denominado “coronasomnia” ou “covidsonia” (Bhat; Chokroverty, 2022).

A depressão e a ansiedade figuram entre os principais fatores associados a distúrbios do sono. Essas condições mentais, frequentemente, manifestam-se com dificuldades para iniciar ou manter o sono, impactando negativamente a qualidade de vida dos indivíduos. Dessa forma, a abordagem desses transtornos mentais revela-se

crucial não apenas para o bem-estar psicológico, mas para a melhoria da qualidade do sono e, por conseguinte, da saúde geral dos pacientes (Arroll *et al.*, 2012).

O transtorno de sono teve repercussões significativas para a vida de idosos com o advento da Covid-19. Essa população enfrentou dificuldades persistentes com a insônia, o que afetou não apenas a qualidade do seu descanso, mas seu bem-estar geral e capacidade de funcionar no dia a dia. Esse cenário ressalta a importância de abordagens específicas que possam ajudar a mitigar esses efeitos e promover uma melhor qualidade de vida (Gong *et al.*, 2023).

Nota-se que alguns dos idosos informam ter iniciado o uso de medicamentos para dormir com o surgimento da pandemia de Covid-19. Isso está alinhado com estudos que indicam aumento significativo no consumo de ansiolíticos, antidepressivos e hipnóticos, nesse período, o que reflete, negativamente, no psicológico e emocional de indivíduos, além de sobrecarregar o sistema público de saúde (Afonso; Santos, 2024; Benistand *et al.*, 2022).

Salienta-se que a insônia vai além de meros distúrbios na iniciação e continuidade do sono, pois desencadeia impactos profundos e abrangentes tanto no âmbito mental quanto físico. Ela compromete o funcionamento em diversas esferas cognitivas e induz desequilíbrios emocionais significativos. Quando crônica, a insônia eleva, consideravelmente, o risco de desenvolvimento de condições graves, como depressão maior e demência de Alzheimer. Ademais, seus efeitos não se restringem ao campo neuropsiquiátrico, pois atingem múltiplos sistemas do organismo, incluindo o imunológico, o endócrino e o circulatório. Isso, por sua vez, aumenta a suscetibilidade a condições como diabetes mellitus, hipertensão arterial, neoplasias e processos infecciosos, evidenciando a amplitude de suas consequências deletérias para a saúde global (Yun, 2021).

Nesse sentido, é indispensável o desenvolvimento de estratégias eficazes para abordar a saúde mental no pós-pandemia, considerando os efeitos duradouros que esse período pode ter causado, a fim de voltar o olhar para grupos vulneráveis, como os idosos, que foram particularmente afetados. Tal situação demanda intervenções específicas, com o uso da Terapia Cognitiva Comportamental, por exemplo, que pode oferecer apoio psicológico especializado para lidar com ansiedade e depressão, além de incentivar relações sociais, dentre outras medidas importantes (Souza *et al.*, 2022).

Além do mais, outros longevos referiram dormir bem, mesmo após terem sido afligidos pela Covid-19.

[...] aí é outra coisa que vou dizer a verdade, hoje durmo melhor, durmo bem. Antes não, antes não tinha hora para dormir e nem a hora para acordar, por conta de consumo de cachaça. Hoje deito ali, antes eu não tinha o costume de tirar cochilo depois de meio dia, almoçar e ver um pouco televisão e dormir um pouco, não tinha, eu levava tudo no esportivo assim. Hoje não, hoje eu pego e durmo normal, meio dia assisto televisão, já tiro mais um cochilo, hoje é melhor, muito melhor minha vida do que antes (S1).

[...] eu não vejo diferença, antes eu dormia bem, graças a Deus, e hoje eu continuo dormindo. Se eu deitar agora eu durmo (riso), então é isso, não afetou o sono (S3).

[...] olha, no início estava ruim, mas hoje tá igual antes, eu durmo muito bem, nossa, até acho muito (riso). Não tenho nenhum problema de sono (S6).

[...] eu passo sono quando vou assistir um filme e eu quero terminar de assistir daí não vou dormir antes de assistir, caso contrário, não tem o porquê passar sono. Eu durmo bem graças a Deus. É comer, beber e dormir (S9).

[...] sim, durmo bem graças a Deus (S10).

Os relatos desses idosos em relação ao sono no pós-contaminação por Covid-19 são positivos. A maioria indica que o sono permaneceu inalterado ou melhorou, por terem adotado um estilo de vida mais saudável após a contaminação. Percebe-se que, nesse grupo específico, não ocorreu alteração negativa no que se refere ao sono, e que a Covid-19 tem ajudado a melhorar em alguns casos.

A infecção por Covid-19 é capaz de afetar, negativamente, diversos sistemas do organismo humano, incluindo o padrão de sono (Andrechuk *et al.*, 2023). No entanto, acredita-se que uma interação complexa entre fatores genéticos e não genéticos desempenha um papel crucial na determinação da resposta imunológica individual e na vulnerabilidade de cada pessoa à infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2. (Ballow; Haga, 2021). Isso pode ter ocorrido em relação a este caso específico.

O Papel da Espiritualidade como Fonte de Apoio Emocional para Idosos durante a Pandemia da Covid-19

Apesar de que os mais velhos sofreram com mais severidade a infecção por Covid-19, alguns se demonstraram resilientes frente às adversidades. Ao analisar as narrativas abaixo, nota-se que a espiritualidade constituiu um elemento crucial de

sustentação emocional e psicológica diante dos desafios impostos pela Covid-19. A fé em uma força divina superior parece ter proporcionado um sentido de transcendência e conforto frente às incertezas e aos medos associados à doença grave e à possibilidade da morte. Para esses indivíduos, a crença religiosa não apenas mitigou o temor da finitude, mas fomentou uma percepção de controle e esperança em um contexto marcado por vulnerabilidade e isolamento.

[...] não, não tive medo de morrer não. Deus que sabe da nossa vida, Deus que nos dá a vida, e o dia marcado por Ele, não tive medo de morrer (S2).

[...] não tive, porque a gente tem que ter fé em Deus, não adianta ter medo, porque quando a coisa vem, vem, não adianta, mas Deus é maior, tem que crer Nele (S11).

[...] não, graças a Deus não tive medo de morrer não (S1).

[...] não tive medo que estava morrendo, porque todos que eu conheci na época que eram intubados, todos que foram intubados, nenhum voltou. Eram intubados e acabaram falecendo. Eu achei que era mais um deles (S5).

A fé em Deus foi um fator importante para propiciar resiliência nos idosos durante a pandemia. Muitos deles expuseram que a crença em uma força maior os ajudou a lidar com o medo e a incerteza da doença. A fé em Deus os fez entender que a vida e a morte são determinadas por Ele, e que não havia motivo para ter medo.

A espiritualidade parece ter proporcionado uma sensação de controle e esperança, permitindo que os idosos enfrentassem a situação de forma mais tranquila. Além disso, a crença de que há algo maior do que a própria vida pode ter ajudado a reduzir o medo da morte.

É interessante notar que, mesmo em situações extremas, a fé pode ser um recurso importante para lidar com as dificuldades e encontrar forças para seguir em frente.

De acordo com Hill e Pargament (2008), indivíduos que possuem uma ligação espiritual segura com Deus tendem a sentir mais conforto diante de circunstâncias desafiadoras, bem como demonstram maior resiliência e autoconfiança no dia a dia. Como resultado natural dessa conexão espiritual sólida, é comum observar reduções nos índices de estresse fisiológico e nos sentimentos de isolamento e solidão.

Nessa perspectiva, a espiritualidade, portanto, emerge como um recurso interno potente, capaz de promover resiliência, oferecer um sentido de paz e aceitação diante das adversidades, destacando sua importância no enfrentamento de situações críticas de saúde e na promoção do bem-estar psicológico dos idosos. Esse aspecto sugere a relevância de considerar a dimensão espiritual no cuidado integral direcionado a essa população, reconhecendo seu potencial de contribuir para estratégias de *coping* e fortalecimento emocional (Almeida; Lopes Júnior; Mendonça, 2024).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo alcançou seu objetivo ao explorar as repercussões da Covid-19 na vida de idosos que superaram a infecção pelo vírus, revelando impactos significativos na saúde mental, emocional e física.

Identificaram-se alterações da memória, efeitos psicopatológicos e emocionais, como medo de recorrência da doença, ansiedade e tristeza.

Foram observadas consequências da infecção pela Covid-19 na saúde física, com sequelas, a exemplo de perda de mobilidade, dormência em membros, fraqueza muscular e comprometimento pulmonar. Essas alterações ressaltam os efeitos prolongados da doença no organismo, exigindo atenção especializada para reabilitação e manejo das condições pós-infecção. Além disso, foram observadas alterações no sono após a infecção, como dificuldade para dormir, o que aconteceu de forma frequente. Isso provocou a necessidade de uso de medicamentos para indução do sono, o que impacta diretamente a qualidade de vida.

A relevância deste estudo está na necessidade de maior atenção à saúde física e mental no período pós-Covid-19, bem como na importância de programas de reabilitação voltados à redução das sequelas da doença. Esses programas devem contemplar aspectos físicos, cognitivos e emocionais, com o objetivo de favorecer a recuperação e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos afetados.

Além disso, a conscientização sobre o apoio emocional necessário para lidar com o medo e ansiedade pós-infecção é fundamental para promover recuperação integral.

O estudo apresenta limitações, como viés de seleção, devido à exclusão de indivíduos com incapacidade cognitiva ou depressão prévia, além da falta de avaliação longitudinal para acompanhar a evolução das sequelas ao longo do tempo.

Sugere-se que os próximos estudos realizem acompanhamento longitudinal para avaliar persistência e evolução das sequelas, bem como incorporem avaliações mentais formais para mensurar, de forma objetiva, os impactos na memória.

REFERÊNCIAS

- AFONSO, Jéssica Guimarães Martins; SANTOS, Jaqueline Rocha Borges. MEDICAMENTALIZAÇÃO NA PANDEMIA DE COVID-19: Consumo de psicofármacos em duas farmácias no sul fluminense. **Psicologia e Saúde em debate**, v. 10, n. 2, p. 615-637, 2024. DOI: 10.22289/2446-922X.V10A2A38
- AHMED, Muhammad Umer *et al.* Neurological manifestations of COVID-19 (SARS-CoV-2): a review. **Frontiers in neurology**, v. 11, p. 518, 2020. doi: 10.3389/fneur.2020.00518
- ALCOFORADO, Beatriz Barbosa; MENDONÇA, Larissa Aguiar. O impacto do consumo de medicamentos controlados nas unidades básicas de saúde pós-pandemia da COVID 19. **Observatório de la Economía Latinoamericana**, v. 23, n. 6, p. e10134-e10134, 2025. DOI: 10.55905/oelv23n6-001
- ALKODAYMI, Mohamad Salim *et al.* Prevalence of post-acute COVID-19 syndrome symptoms at different follow-up periods: a systematic review and meta-analysis. **Clinical Microbiology and Infection**, v. 28, n. 5, p. 657-666, 2022. doi.org/10.51891/rease.v10i11.16798.
- ALMEIDA ALEXANDRE, Clara Mel; JÚNIOR, Hélio Marco Pereira Lopes; MENDONÇA, Francisco Cardoso. Espiritualidade e qualidade de vida: uma revisão dos efeitos positivos na saúde mental. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 11, p. 4805-4816, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i11.16798>
- ALMEIDA, Wilma Rodrigues Santos *et al.* Sintomas de ansiedade em adultos jovens: a atuação do profissional de psicologia na atenção básica. **Debates em Psiquiatria**, v. 12, p. 1-22, 2022. DOI: <https://doi.org/10.25118/2763-9037.2022.v12.314>
- ALSAGHEIR, Aeshah *et al.* A National Survey of Children, Adults, and the Elderly in the Fourth Wave of the COVID-19 Pandemic to Compare Acute and Post-COVID-19 Conditions in Saudi Arabia. **Journal of clinical medicine**, v. 12, n. 6, p. 2242, 2023. doi.org/10.3390/jcm12062242
- AMARANTE, Paulo (Ed.). **Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil**. Rio de Janeiro, SciELO-Editora FIOCRUZ, 1998.
- AMORIM, Sandra Fernandes; ALMEIDA LOPES, Sandra Ribeiro. **Saúde e psicologia: dilemas e desafios da prática na atualidade**. São Paulo, Paco e Littera, 2022.
- ANDRECHUK, Carla Renata Silva *et al.* The impact of the COVID-19 pandemic on sleep disorders among Nursing professionals. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 31, p. e3795, 2023. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.6043.3795>
- ARAÚJO, Eduarda Gomes Onofre *et al.* Impactos da pandemia de COVID-19 na saúde física dos idosos: uma revisão integrativa. **Research, Society and**

Development, v. 11, n. 9, p. e7411931577-e7411931577, 2022.

<https://doi.org/10.1055/s-0044-1800941>

ARAÚJO, Ellen Oliveira. O aumento do uso de antidepressivos e ansiolíticos pós pandemia e seus impactos. **Publicações**, 2023. DOI 10.47402/ed.ep.c2311294289

ARROLL, Bruce *et al.* Prevalence of causes of insomnia in primary care: a cross-sectional study. **The British Journal of General Practice**, v. 62, n. 595, p. e99, 2012. doi: [10.3399/bjgp12X625157](https://doi.org/10.3399/bjgp12X625157)

ARTHUR, Neliane *et al.* Os caminhos da loucura: Recortes sobre o papel do louco e os cuidados em saúde mental na história. **Cadernos Brasileiros de Saúde Mental/Brazilian Journal of Mental Health**, v. 14, n. 38, p. 74-90, 2022.

DOI: <https://doi.org/10.5007/cbsm.v14i38.69521>

ASSIRI, Abdullah *et al.* Epidemiological, demographic, and clinical characteristics of 47 cases of Middle East respiratory syndrome coronavirus disease from Saudi Arabia: a descriptive study. **The Lancet infectious diseases**, v. 13, n. 9, p. 752-761, 2013.

ASSIS, Daiana Constancio dos Santos *et al.* A Covid-19 sob a ótica de uma revisão integrativa. **Revista Saúde e Inovação**, v. 1, n. 1, p. 1-12, 2020. DOI:

<https://doi.org/10.51208/saudeinovacao.v1i1.15>

BAHAROON, Salim; MEMISH, Ziad A. MERS-CoV as an emerging respiratory illness: a review of prevention methods. **Travel medicine and infectious disease**, v. 32, p. 101520, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2019.101520>

BALLOW, Mark; HAGA, Christopher L. Why do some people develop serious COVID-19 disease after infection, while others only exhibit mild symptoms? **The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice**, v. 9, n. 4, p. 1442-1448, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2021.01.012>

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2016.

BHAT, Sushanth; CHOKROVERTY, Sudhansu. Sleep disorders and COVID-19.

Sleep medicine, v. 91, p. 253-261, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.07.021>

BARROS, Juliana Cerqueira; SILVA, Sarah Nascimento. Perfil de utilização de psicofármacos durante a pandemia de COVID-19 em Minas Gerais, Brasil. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 26, p. e230059, 2023. <https://doi.org/10.1590/1980-549720230059.2>

BENASSI, Cassiane Beatrís Pasuck; CANCIAN, Queli Ghilardi; STRIEDER, Dulce Maria. Estudo piloto: Um instrumento primordial para a pesquisa de percepção da ciência. **Ensino e Tecnologia em Revista**, v. 7, n. 1, p. 210-225, 2023.

DOI: [10.3895/etr.v7n1.16725](https://doi.org/10.3895/etr.v7n1.16725)

BRASIL, Ministério da Saúde. **Recomendação Nº 036, de 11 de maio de 2020**. Brasília, 2020c. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/recomendacoes/2020/recomendacao-no-036.pdf/view>. Acesso em: 08 out. 2024.

BRASIL, Fiocruz. **Qual a origem do novo coronavírus?**. Fiocruz, 2022a. Disponível em: https://fiocruz.br/busca?search_api_fulltext=tipos%20de%20coronav%C3%ADrus&page=4. Acesso em: 02 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Coronavírus**: o que você precisa saber e como prevenir o contágio, 2022b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/search?origem=historico&SearchableText=Coronav%C3%ADrus:%20o%20que%20voc%C3%AA%20precisa%20saber%20e%20como%20prevenir%20o%20cont%C3%A1gio>. Acesso em: 16 nov. 2024

BRASIL, Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE), Em 2023, expectativa de vida chega aos 76,4 anos e supera patamar pré-pandemia. Brasil, 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41984-em-2023-expectativa-de-vida-chega-aos-76-4-anos-e-supera-patamar-pre-pandemia>. Acesso em: 02 nov. 2025.

BRITTO, Renata Corrêa; AMARANTE, Paulo. Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira e Garantia dos Direitos de Cidadania das Pessoas com Transtornos Mentais-Análise de sua aplicação. **Rev. saúde pública Mato Grosso Sul**, p. 7-12, 2007.

BRONFENBRENNER, Urie; MORRIS, P. A. **A ecologia do desenvolvimento humano**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

BRUNA, Maria Helena Varella. **SARS/SRAG**: síndrome respiratória aguda grave [Internet]. 2022 [acesso em: 06 out. 2025]. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/sars-srag-sindrome-respiratoria-aguda-grave/>

CAMPOS, Simone Cristina; FLORIANO, Lara Simone Messias. COVID-19 E A SAÚDE MENTAL DE PESSOAS IDOSAS PARTICIPANTES EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA. **ARACÊ**, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 8000–8021, 2024. DOI: [10.56238/arev6n3-219](https://doi.org/10.56238/arev6n3-219)

CARVALHO, Larissa Clementino Leite Sá; SILVA, Priscila Aparecida; ROCHA-FILHO, Pedro Augusto Sampaio. Persistent headache and chronic daily headache after COVID-19: a prospective cohort study. **The Korean Journal of Pain**, v. 37, n. 3, p. 247-255, 2024. <https://doi.org/10.3344/kjp.24046>

CASTRO, Rosana. Vacinas contra a Covid-19: o fim da pandemia? **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 31, p. e310100, 2021.

CATALDI, Mauro; PIGNATARO, Giuseppe; TAGLIALATELA, Maurizio. Neurobiology of coronaviruses: potential relevance for COVID-19. **Neurobiology of Disease**, v. 143, p. 105007, 2020. doi:10. 1016/j.nbd.2020.105007

CDC. Centers for Disease Control and Prevention. **Symptoms of COVID-19**. United State Government, 2024. Disponível em: <https://www.cdc.gov/covid/signs-symptoms/index.html>. Acesso em: 20 out. 2024.

CENEDESI JÚNIOR, Mario Angelo *et al.* Anxiety in the elderly in the context of the COVID-19 pandemic. **Revista Contribuciones a Las Ciencias Sociales**, São José dos Pinhais, v.16, n.11, p. 28665-28676, 2023. DOI: <https://doi.org/10.55905/revconv.16n.11-234>

CÉZAR, Michelle de Almeida; COELHO, Mayara Pacheco As experiências de reforma psiquiátrica ea consolidação do movimento brasileiro: uma revisão de literatura. Mental [Internet]. 2017. https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-44272017000100008

CONASS. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. (2017). Atenção Primária à Saúde é capaz de resolver 85% das demandas de saúde. Brasília: CONASS. 2019. Disponível em: <https://www.conass.org.br/atencao-primaria-e-capaz-de-resolver-85-das-demandas-de-saude/>. Acesso em 4 set. 2025.

Coronavirus Resource Center. **COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Enginne**. Johns Hopkins University & Medicine, 2023.

CUADRADO, Esther *et al.* The Moderating Role of Perceived Efficacy of COVID-19 Prevention Measures on the Relation Between Perceived Risk and Perceived Mental Health. **Anales de Psicología/Annals of Psychology**, v. 40, n. 1, p. 12-19, 2024.

CUNHA, Camila Abreu Pinto *et al.* A saúde mental dos idosos em tempos de pandemia: uma revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 2, p. e9636-e9636, 2022.

DIAS, Diogo Antunes *et al.* Depressão entre pessoas idosas hospitalizadas: estudo de métodos mistos. **Ciênc. cuid. saúde**, p. e65795-e65795, 2023.

DO BÚ, Emerson Araújo *et al.* Representações e ancoragens sociais do novo coronavírus e do tratamento da COVID-19 por brasileiros. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, v. 37, p. e200073, 2020.

DZIF. German Center for Infection Research. Vaccine against the MERS coronavirus tested as safe and effective in phase Ib clinical trial. [Internet], 2024. Acessado em 06 out. 2025. Disponível em: <https://www.dzif.de/en/vaccine-against-mers-coronavirus-tested-safe-and-effective-phase-ib-clinical-trial>

FACUNDES, André Everton; SILVA, Bruno Nunes Rodrigues; PIROZZI, Flavio Fontes. Endocrinopatias e sua associação com distúrbios psiquiátricos: uma revisão integrativa: Endocrinopathies and their association with psychiatric disorders: an integrative review. **Ulakes Journal Of Medicine**, v. 3, n. 3, 2023.

FEHR, Anthony R.; PERLMAN, Stanley. Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis. **Coronaviruses: methods and protocols**, p. 1-23, 2015.

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS, César *et al.* Trajectory of post-COVID brain fog, memory loss, and concentration loss in previously hospitalized COVID-19 survivors: the LONG-COVID-EXP multicenter study. **Frontiers in Human Neuroscience**, v. 17, p. 1259660, 2023. DOI: 10.3389/fnhum.2023.1259660

FERRAZZA, Daniele de Andrade *et al.* A banalização da prescrição de psicofármacos em um ambulatório de saúde mental. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, v. 20, p. 381-390, 2010. <https://doi.org/10.1590/S0103-863X2010000300010>

FIOCRUZ. Memória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro, 1978. Disponível em: <https://laps.ensp.fiocruz.br/linha-do-tempo/1>. Acesso em: 16 set. 2025.

FIOCRUZ. 2050: Brasil terá 30% da população acima dos 60 anos. 2017. Disponível em: <https://saudeamanha.fiocruz.br/2050-brasil-tera-30-da-populacao-acima-dos-60-anos/sem-categoria/>. Acesso em: 04 set. 2025.

FONSECA, João José Saraiva. **Apostila de metodologia da pesquisa científica**. João José Saraiva da Fonseca, 2002. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=oB5x2SChpSEC&oi=fnd&pg=PA4&dq=Apostila+de+metodologia+da+pesquisa+cient%C3%ADfica&ots=OSUU3vfpm4&sig=DpztN6_Px-EGtIO97I7Y-TzINO0&redir_esc=y#v=onepage&q=Apostila%20de%20metodologia%20da%20pesquisa%20cient%C3%ADfica&f=false. Acesso em: 20 out. 2024.

FONTANELLA, Bruno José Barcellos; RICAS, Janete; TURATO, Egberto Ribeiro. Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. **Cadernos de saúde pública**, v. 24, p. 17-27, 2008. <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2008000100003>

FREITAS, Adriana Valéria Da Silva *et al.* Repercussions of social isolation of elderly people during the covid-19 pandemic. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 36, 2022. DOI: 10.18471/rbe.v36.37598

FURTADO, Michelli Janisch *et al.* A pandemia da Covid-19: revisão da literatura. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 1, p. 5810-5826, 2023. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv9n1-395>

GARG, Ravindra Kumar; PALIWAL, Vimal Kumar; GUPTA, Ankit. Spinal cord involvement in COVID-19: a review. **The Journal of Spinal Cord Medicine**, v. 46, n. 3, p. 390-404, 2023. <https://doi.org/10.1080/10790268.2021.1888022>

GARRIGUES, Eve *et al.* Post-discharge persistent symptoms and health-related quality of life after hospitalization for COVID-19. **Journal of Infection**, v. 81, n. 6, p. e4-e6, 2020. doi:10.1016/j.jinf.2020.08.029

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record, 1997.
HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro Tributário. Rev., atual. e ampl. **São Paulo: Atlas**, 2016.

GONG, Kirsten *et al.* Insomnia symptoms among older adults during the first year of the COVID-19 pandemic: A longitudinal study. **Sleep Health**, v. 9, n. 4, p. 560-566, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2023.04.008>

GREENBLATT-KIMRON, Lee *et al.* Depression and medicine use among older adults during the COVID-19 pandemic: the role of psychosocial resources and COVID-19 perceived susceptibility. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 20, n. 4, p. 3398, 2023. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043398>

GREENHALGH, Trisha *et al.* Management of post-acute covid-19 in primary care. **bmj**, v. 370, 2020. doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.m3026>

GUGLIOTTI, Larissa Santos *et al.* Impacto do isolamento social em idosos na pandemia covid-19. **REVISA**, v. 13, n. 3, p. 650-660, 2024. Doi: <https://doi.org/10.36239/revisa.v13.n3.p650a660>

HAN, Madeline FY; MAHENDRAN, Rathi; YU, Junhong. Associations between fear of COVID-19, affective symptoms and risk perception among community-dwelling older adults during a COVID-19 lockdown. **Frontiers in psychology**, v. 12, p. 638831, 2021. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.638831>

HENNEGHAN, Ashley M. *et al.* Cognitive impairment in non-critical, mild-to-moderate COVID-19 survivors. **Frontiers in Psychology**, v. 13, p. 770459, 2022. doi: 10.3389/fpsyg.2022.770459

HILL, Peter C.; PARGAMENT, Kenneth I. Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: Implications for physical and mental health research. 2008. DOI: 10.1037/0003-066X.58.1.64

HOLEVA, Vasiliki *et al.* Fear of COVID-19, anxiety, depression and suicide among elderly patients with chronic physical or mental diseases. **Journal of Mind and Medical Sciences**, v. 9, n. 2, p. 266-275, 2022. doi: 10.22543/2392-7674.1318

HUANG, Yiyi *et al.* Impact of coronavirus disease 2019 on pulmonary function in early convalescence phase. **Respiratory research**, v. 21, n. 1, p. 163, 2020. <https://doi.org/10.1186/s12931-020-01429-6>

IBGE. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. **Censo 2022**. Cidades e Estados. IBGE 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/cascavel.html>. Acesso em: 02 nov. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. Em 2023, expectativa de vida chega aos 76,4 anos, e supera o patamar pré-pandêmico. IBGE, 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/38455-em-2022-expectativa-de-vida-era-de-75-5-anos>. Acesso em: 04 set. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. **Censo 2022**: católicos seguem em queda; evangélicos e sem religião crescem, IBGE, 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43593-censo-2022-catolicos-seguem-em-queda-evangelicos-e-sem-religiao-crescem-no-pais>. Acesso em 04 set. 2025.

JESTE, Dilip V. *et al.* Study of loneliness and wisdom in 482 middle-aged and oldest-old adults: a comparison between people in Cilento, Italy and San Diego, USA. **Aging & Mental Health**, v. 25, n. 11, p. 2149-2159, 2021. DOI: [10.1080/13607863.2020.1821170](https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1821170)

JOSEPH, Letha Mullamkuzhy. Impact of COVID-19 on mental health and emotional well-being of older adults. **World journal of virology**, v. 11, n. 3, p. 129, 2022. doi: [10.5501/wjv.v11.i3.129](https://doi.org/10.5501/wjv.v11.i3.129)

KARMANN, Julie *et al.* Resilience among older adults during the COVID-19 pandemic: A photovoice study. **SSM-Qualitative Research in Health**, v. 3, p. 100256, 2023. doi: [10.1016/j.ssmqr.2023.100256](https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2023.100256)

KRISHNAN, Kamini *et al.* Multidisciplinary approach to brain fog and related persisting symptoms post COVID-19. **Journal of health service psychology**, v. 48, n. 1, p. 31-38, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s42843-022-00056-7>

LAU, Hien *et al.* Internationally lost COVID-19 cases. **Journal of Microbiology, Immunology and Infection**, v. 53, n. 3, p. 454-458, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.03.013>

LIANG, Jun *et al.* The Impact of Social Support for Patients with COVID-19 in Post-Traumatic Growth: A Mediating Analysis Study. **Journal of Multidisciplinary Healthcare**, p. 3593-3603, 2025. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S514665>

LEMOS, Vanessa Santos; LHULLIER, Cristina. A psicologia na atenção básica e a saúde coletiva. **Revista Psicologia e Saúde**, v. 12, n. 3, p. 177-188, 2020.

LIMA, Thaynara; BORTOLINI, Maria Cátira. Arms Race: Coevolução vírus-hospedeiro com foco na família Coronaviridae. **BIO Diverso**, v. 2, n. 1, 2022.

LIM, So Young *et al.* Nutritional factors affecting mental health. **Clinical Nutrition Research**, v. 5, n. 3, p. 143, 2016. <http://doi.org/10.7762/cnr.2016.5.3.143>

LOPES, Lara Bourguignon; SOUZA, Gabriele Teixeira Braz de; BARBOSA, Roberta Ribeiro Batista. Muscle strength in patients hospitalized for COVID-19. **Fisioterapia em Movimento**, v. 37, p. e37105, 2024. <https://doi.org/10.1590/fm.2024.37105>

MACÊDO NETO, Olavo Leite; DE MACÊDO, Paulo Ayslen Nascimento. DESAFIOS DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. **REVISTA FOCO**, v. 18, n. 6, p. e8911-e8911, 2025. DOI: 10.54751/revistafoco.v18n6-212

MARINHO, Jercy Gabriella Gomes; DE OLIVEIRA, Maikon Chaves; CARNEIRO, Ana Maria Costa Teixeira. Impactos do isolamento social na saúde mental de idosos na pandemia da Covid-19—uma revisão de literatura. **Humanidades & Inovação**, v. 10, n. 14, p. 330-342, 2023.

<https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/view/8867>

MARROCOS, Elisabelle Martins *et al.* Percepção dos idosos sobre as repercussões da pandemia por COVID-19 em sua saúde. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p. e41010918067-e41010918067, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i9.18067>

MATTA, Gustavo Côrrea *et al.* Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. **Políticas de saúde: organização e operacionalização do Sistema Único de Saúde**, p. 61-80, 2007.

MEDEIROS, Gabriely Quintana *et al.* Efetividade das vacinas da COVID-19 e disseminação do vírus: revisão sistemática. **Revista Neurociências**, v. 31, p. 1-23, 2023.

MEDEIROS POSSATTO, Jessica; RABELO, Dóris Firmino. Condições de saúde psicológica, capacidade funcional e suporte social de idosos. **Revista Kairós-Gerontologia**, v. 20, n. 2, p. 45-58, 2017.

MENDONCA FILHO, Valder Cavalcante Maia *et al.* COVID-19 in the nervous system: physiopathology and neurological manifestations. **Arquivos de neuro-psiquiatria**, v. 81, n. 08, p. 756-763, 2023. DOI: 10.1055/s-0043-1769123

MHF, Mental Health Foundation **Factors that affect mental health**. UK, 2022. Disponível em: <https://www.mentalhealth.org.uk/explore-mental-health/factors-affect-mental-health#paragraph-47731>. Acesso em: 20 set. 2025.

MOAYED, Malihe Sadat *et al.* Depression, anxiety, and stress among patients with COVID-19: a cross-sectional study. **Clinical, Biological and Molecular Aspects of COVID-19**, p. 229-236, 2021.

MONTANI, David *et al.* Post-acute COVID-19 syndrome. **European Respiratory Review**, v. 31, n. 163, 2022.

NAKAGOMI, Atsushi *et al.* Social isolation and subsequent health and well-being in older adults: A longitudinal outcome-wide analysis. **Social science & medicine**, v. 327, p. 115937, 2023.

NARCISO, lasmin *et al.* O isolamento social no contexto da pandemia covid-19 ea saúde mental: perspectivas de idosos institucionalizados. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 27, p. e230172, 2024. <https://dx.doi.org/10.1590/1981-22562024027.230172.pt>

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. **Impact of the DSM-IV to DSM-5 Changes on the National Survey on Drug Use and Health** [Internet]. 2016.. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519704/table/ch3.t36/>. Acesso em: 28 set 2025.

NIH. National Institutes of Health **Mental Disorders and Related Topics**. 2024. Disponível em: <https://www.nimh.nih.gov/health/topics>. Acesso em: 28 set. 2025

NVivo, versão 15. 2024. **Software para análise de dados qualitativos**. Disponível em: <https://lumivero.com/products/nvivo/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

OLIVEIRA, Gilvano Amorim; OLIVEIRA, Giovana Martins Lopes. Covid-19 in familial cluster: ultrashort incubation period could be an early indication of Brazilian Variant of SARS-Cov-2 virus? **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 4, p. e6726-e6726, 2021.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. OMS divulga lista de doenças e patógenos prioritários para pesquisa e desenvolvimento em 2018. 2018. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/14-2-2018-oms-divulga-lista-doencas-e-patogenos-prioritarios-para-pesquisa-e>

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Países das Américas aprovam resolução da OEA para enfrentar crise de saúde mental na região. Antigua e Barbuda, 2025. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/27-6-2025-paises-das-americas-aprovam-resolucao-da-oea-para-enfrentar-crise-saude-mental>

OMS. Organização Mundial da Saúde. **Mental health**. 2022. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health>. Acesso em: 26 jul. 2024.

OUSSEIRAN, Zeina Hassan; FARES, Youssef; CHAMOUN, Wafaa Takash. Neurological manifestations of COVID-19: a systematic review and detailed comprehension. **International Journal of Neuroscience**, v. 133, n. 7, p. 754-769, 2023.

OXFAM. Acesso à educação no Brasil: os desafios da luta pela igualdade. 2021. Disponível em: <https://www.oxfam.org.br/blog/acesso-a-educacao-no-brasil-os-desafios-da-luta-pela-igualdade/>. Acesso em: 04 set. 2025.

PECOITS, Roberta Vieira *et al.* O impacto do isolamento social na saúde mental dos idosos durante a pandemia da Covid-19. **REVISTA AMRIGS**, 2021.

PELBART, Peter Pal. **Da clausura do fora ao fora da clausura**. São Paulo: Brasiliense, 1989.

PEDREIRA, Rhaine Borges Santos *et al.* Impactos reais e/ou potenciais da pandemia de COVID-19 na saúde mental de idosos. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 26, n. 3, 2022.

DOI: 10.25110/arqsaude.v26i3.2022.8488

PEREIRA, Wandyk Allisson Bernardes *et al.* Aumento da expectativa de vida e crescimento populacional no Brasil e os impactos no número de pessoas vivendo

com doenças crônico-degenerativas: desafios para o manejo da Doença de Alzheimer. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 5, p. e24112531673-e24112531673, 2023.

PESSOTTI, Isaias. **Os nomes da loucura**. São Paulo. Editora 34, 1999. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=aGlzoiXlbpkC&oi=fnd&pg=PA15&dq=Os+nomes+da+loucura&ots=soWH7eghXz&sig=M6J-Q-8IRfCykX7yMec-dP2eUAo&redir_esc=y#v=onepage&q=Os%20nomes%20da%20loucura&f=false. Acesso em 27 out. 2025.

PIERRE, Alexandre et al. Muscle weakness after critical illness: unravelling biological mechanisms and clinical hurdles. **Critical Care**, v. 29, n. 1, p. 248, 2025. <https://doi.org/10.1186/s13054-025-05462-z>

PIOVESAN, Armando; TEMPORINI, Edméa Rita. Pesquisa exploratória: procedimento metodológico para o estudo de fatores humanos no campo da saúde pública. **Revista de saúde pública**, v. 29, p. 318-325, 1995.

PORTO, Elias Ferreira *et al.* Mortalidade por Covid-19 no Brasil: perfil sociodemográfico das primeiras semanas. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 1, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i1.11588>.

POZZOBON, Cesar Romaro *et al.* O Impacto da Cardiopatia Grave nas Causas de Óbito e Sobrevida após Aposentadoria por Invalidez. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 121, n. 9, p. e20240068, 2024. <https://doi.org/10.36660/abc.20240068>

PRADO, Marcelo Freitas do *et al.* Análise da subnotificação de COVID-19 no Brasil. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 32, p. 224-228, 2020. DOI: 10.5935/0103-507X.20200030.

PRANDONI, Raul Fernando Sotelo; PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza. A reforma psiquiátrica no Brasil: eu preciso destas palavras. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 13, p. 633-640, 2004.

PRATES, Leonardo Teixeira et al. saúde mental do idoso pós pandemia de covid-19: uma revisão integrativa. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 10, p. e6256-e6256, 2024. DOI: 10.56083/RCV4N10-155

QIU, Wuqi *et al.* The pandemic and its impacts. **Health, culture and society**, p. 1, 2017. DOI 10.5195/hcs.2017.221.

RAJMOHAN, Velayudhan; APARNA, N. M. Prevalence of depressive and anxiety symptoms and perceived stress in hospitalised patients with COVID-19. **East Asian Archives of Psychiatry**, v. 34, n. 1, p. 9-13, 2024.

RAVINDRA, Khaiwal *et al.* Asymptomatic infection and transmission of COVID-19 among clusters: systematic review and meta-analysis. **Public Health**, v. 203, p. 100-109, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2021.12.003>

RODRIGUES, Beatriz Gonçalves *et al.* Saúde mental do idoso em tempos de COVID-19. **New Trends in Qualitative Research**, v. 18, p. e834-e834, 2023.

RODRIGUEZ, Belén *et al.* Development and early diagnosis of critical illness myopathy in COVID-19 associated acute respiratory distress syndrome. **Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle**, v. 13, n. 3, p. 1883-1895, 2022. DOI: 10.1002/jcsm.12989

ROŽMAN, Maja; VREČKO, Igor; TOMINC, Polona. Psychological Factors Impacting Academic Performance Among Business Studies' Students. **Education Sciences**, v. 15, n. 2, p. 121, 2025. <https://doi.org/10.3390/educsci15020121>

SANTOS, Angela Carla Leandro Vieira *et al.* **Intervenção em saúde mental: promovendo conscientização e quebrando estigmas em ambientes educacionais.** Cariacica, ES. Editora Manual, 2025.

SARAIVA, Elyadna Gadelha *et al.* CAPÍTULO 6 ALTERAÇÕES ANATOMO-FISIOLÓGICAS NA PESSOA IDOSA E A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SENESCÊNCIA E NA SENILIDADE. **SAÚDE a serviço da vida**, p. 121. 2020.

SER. **Rompendo barreiras: Superando o estigma de buscar ajuda psicológica.** 2024. Disponível em: <https://www.experimenteser.com.br/sem-categoria/rompendo-barreiras-superando-o-estigma-de-buscar-ajuda-psicologica/#:~:text=A%20busca%20por%20apoio%20psicol%C3%B3gico%20%C3%A9%20um,explora%20algumas%20das%20raz%C3%B5es%20por%20tr%C3%A1s%20da>. Acesso em: 06 set. 2025.

SEYFERTH, Giralda. Colonização, imigração e a questão racial no Brasil. **Revista usp**, n. 53, p. 117-149, 2002.

SILVA FILHO, Aloisio Machado da *et al.* Anos potenciais de vida perdidos devido à covid-19, segundo a raça/cor e gênero, no Brasil, entre 2020 e 2021. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, p. e04702023, 2024. DOI: 10.1590/1413-81232024293.04702023

SILVA, Henrique Salmazo *et al.* Compreensões da enfermagem sobre segurança do paciente idoso hospitalizado na emergência em tempos de covid-19. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 96, n. 38, 2022.

SILVA, Tiago Ribeiro; MARIOTTI, M. C.; BRIDI, A. Aprendendo a lidar com as mudanças de rotina devido ao COVID-19: Orientações Práticas para Rotinas Saudáveis. **Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional**, 2020.

SILVEIRA, Lia Carneiro; BRAGA, Violante Augusta Batista. Acerca do conceito de loucura e seus reflexos na assistência de saúde mental. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 13, p. 591-595, 2005.

SOUSA, José Roberto Azevedo *et al.* SAÚDE MENTAL EM MEIO AS ROTINAS DIÁRIAS. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 8, p. 2050-2055, 2023.

SOUZA, Aline Pereira de *et al.* Mental health promotion and protection actions aimed at the elderly in the context of primary health care: an integrative review. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, p. 1741-1752, 2022. DOI: 10.1590/1413-81232022275.23112021EN

SOUZA, Nathalia Rodrigues *et al.* O aumento do uso de antidepressivos e ansiolíticos pós pandemia e seus impactos. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 12, n. 1, 2024. doi: <https://doi.org/10.61164/rnm.v12i1.2956>

STATSENKO, Yauhen *et al.* Impact of age and sex on COVID-19 severity assessed from radiologic and clinical findings. **Frontiers in cellular and infection microbiology**, v. 11, p. 777070, 2022. doi: 10.3389/fcimb.2021.777070

SUBBARAO, Kanta; ROBERTS, Anjeanette. Is there an ideal animal model for SARS?. **Trends in microbiology**, v. 14, n. 7, p. 299-303, 2006. [https://www.cell.com/trends/microbiology/fulltext/S0966-842X\(06\)00127-2](https://www.cell.com/trends/microbiology/fulltext/S0966-842X(06)00127-2)

TAN, Chee-Wah *et al.* Pan-sarbecovirus neutralizing antibodies in BNT162b2-immunized SARS-CoV-1 survivors. **New England Journal of Medicine**, v. 385, n. 15, p. 1401-1406, 2021. DOI: 10.1056/NEJMoa2108453

TAVARES-JÚNIOR, José Wagner *et al.* Long COVID: neurological manifestations-an updated narrative review. **Dementia & neuropsychologia**, v. 18, p. e20230076, 2024. <https://doi.org/10.1590/1980-5764-DN-2023-0076>

TEIXEIRA, Giovanna Rodrigues. O impacto da pandemia da covid-19 na saúde mental dos idosos. **Publicações**, 2023. DOI 10.47402/ed.ep.c23218518119

TRIVINOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à pesquisa em ciências sociais**. São Paulo, Editora Atlas S.A. v. 133, 1987. Disponível em: <https://bibliocetas.fct.unesp.br/Arquivos%20P%C3%BAblicos/Pesquisa%20Qualitativa%20Trivi%C3%B1os%20-%20Introdu%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20pesquisa%20em%20Ci%C3%AAncias%20Sociais-Cap%C3%ADtulos%20II-III-IV.pdf>. Acesso em 27 out. 2025.

ONU. United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects. 2022. Disponível em: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf. Acesso em: 20 jul. 2024.

UZUNIAN, Armênio. Coronavirus SARS-CoV-2 and Covid-19. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, v. 56, p. e3472020, 2020.

VICENTE, Mateus Carneiro *et al.* Resiliência em pessoas idosas diante da pandemia COVID-19: revisão integrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 36, p. eAPE022032, 2023. DOI: [10.37689/acta-ape/2023AR022032](https://doi.org/10.37689/acta-ape/2023AR022032)

VIEIRA, Kelma Cristina et al. O impacto da solidão e o isolamento social na saúde mental dos idosos. **Revista Contemporânea**, v. 5, n. 7, p. e8659-e8659, 2025. DOI: 10.56083/RCV5N7-098

VIRLOGEUX, Victor *et al.* Comparison of incubation period distribution of human infections with MERS-CoV in South Korea and Saudi Arabia. **Scientific reports**, v. 6, n. 1, p. 35839, 2016. DOI: 10.1038/srep35839 6

WHO. COVID-19 Cases, World. Geneva, 2023. Disponível em: <https://covid19.who.int/>. Acesso em: 06 set. 2024

WHO. **SARS outbreak contained worldwide**. Geneva, 2003. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/05-07-2003-sars-outbreak-contained-worldwide>. Acesso em: 28 set. 2025

WHO. **Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)**. WHO, 2020a. Disponível em: [https://www.who.int/publications/i/item/report-of-the-who-china-joint-mission-on-coronavirus-disease-2019-\(covid-19\)](https://www.who.int/publications/i/item/report-of-the-who-china-joint-mission-on-coronavirus-disease-2019-(covid-19)). Acesso em: 09 jul. 2024.

WHO. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020b. Disponível em: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. Acesso em: 09 jul. 2024.

WHO. World mental health report: Transforming mental health for all. Geneva, 2022a. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>. Acesso em: 16 nov. 2024.

WHO. **Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)**. Geneva. 2022b. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-\(mers-cov\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)). Acesso em: 28 set. 2025

WHO. **Mental health of older adults**. Geneva. 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults>. Acesso em: 15 nov. 2024

WHO. **Saúde mental**. Geneva, 2025a. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>. Acesso em: 28 set. 2025

WHO **Over a billion people living with mental health conditions – services require urgent scale-up**. 2025b. <https://www.who.int/news/item/02-09-2025-over-a-billion-people-living-with-mental-health-conditions-services-require-urgent-scale-up>. Acesso em: 28 set 2025

WILLIAMSON, Elizabeth J. *et al.* Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. **Nature**, v. 584, n. 7821, p. 430-436, 2020.

YANG, Xiaobo *et al.* Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. **The lancet respiratory medicine**, v. 8, n. 5, p. 475-481, 2020.

YUN, Seokho; JO, Sohye. Understanding insomnia as systemic disease. **Yeungnam University journal of medicine**, v. 38, n. 4, p. 267-274, 2021.
<https://doi.org/10.12701/yujm.2021.01424>

ZANINOTTO, Paola *et al.* Immediate and longer-term changes in the mental health and well-being of older adults in England during the COVID-19 pandemic. **JAMA psychiatry**, v. 79, n. 2, p. 151-159, 2022. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.3749

ZHANG, Zeyu *et al.* Trajectory of COVID-19 response and management strategy in China: scientific rationale driven strategy adjustments. **Frontiers of Medicine**, p. 1-12, 2024.

APÊNDICE

Apêndice A - Instrumento de coleta de dados

Instrumento de coleta de dados

Pesquisa:

SAÚDE MENTAL DE IDOSOS APÓS INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA POR COVID-19

I - Identificação do Idoso

Data:
Nome completo:
Telefone de contato:
Sexo do idoso: ☐ Masculino ☐ Feminino

INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS

IDADE _____ anos

ESTADO CIVIL

- ☐ Casado (a)/Companheiro (a) ☐ sim ☐ não
☐ Solteiro (a)
☐ Divorciado (a)/Separado (a)
☐ Viúvo (a)
☐ Namorando

ETNIA

- ☐ branca
☐ negra
☐ parda ou morena
☐ amarela
☐ vermelha
☐ não sabe ou não quis informar

ESCOLARIDADE

- ☐ Analfabeto
☐ Ensino fundamental completo
☐ Ensino fundamental incompleto
☐ Ensino médio completo
☐ Ensino médio incompleto
☐ Ensino superior completo
☐ Ensino superior incompleto

RENDA FAMILIAR

- ☐ Possui Ocupação? ☐ sim ☐ não
☐ Recebe aposentadoria/pensão? Se
 sim, quanto _____

Possui casa própria ou mora de aluguel? () casa própria () aluguel

Quantas pessoas moram na casa? _____.

Relação: _____

Religião: () católica () evangélica () muçulmana () ateu () espírita () não possui

Quando fica doente, qual serviço procura? () APS () UPA () plano de saúde

Você já consultou com psicólogo ou psiquiatra? () sim () não

Se sim, quando? () nos últimos 3 meses () nos últimos 6 meses () nos últimos 12 meses () nos últimos 2 anos () há mais de 2 anos

Ainda está em acompanhamento? () sim () não

Qual foi o diagnóstico? _____

Toma algum medicamento prescrito por psiquiatra ou algum psicotrópico? () sim () não, se sim, qual? _____

Desde que idade você toma o medicamento? _____

ROTEIRO ENTREVISTA

1. Como a covid-19 e o isolamento social afetou a sua vida cotidiana?
2. Você teve medo de adoecer ou morrer?
3. Você conhece alguém que sofreu com a covid-19? Se sim, qual a relação entre você e a pessoa, e de que maneira esse sofrimento afetou a sua vida?
4. Como foi a experiência de ter tido a infecção por covid-19?
5. Você considera que adquiriu algum problema psicológico/mental após a infecção ou surgimento da covid-19?
6. Você fazia algum tratamento ou acompanhamento psicológico ou psiquiátrico antes da pandemia, considera que o problema aumentou com a infecção ou surgimento da covid-19?
7. Como você avalia o seu estado emocional antes e após a covid-19?
8. Como você avalia o funcionamento da sua memória com o advento da pandemia ou após infecção por vírus da covid-19?
9. Como você avalia a qualidade do seu sono antes e após a infecção por covid-19?
10. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?

Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP



Aprovado na
CONEP em 04/08/2000

ANEXO I TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Título do Projeto: A Saúde Mental dos Idosos que Foram Internados na Unidade de Terapia Intensiva Devido a Infecção Pelo Vírus da Covid-19

Pesquisador responsável e colaboradores: Gicelle Galvan Machineski: Tel. (45) 9981-0684

Caro, convidamos você a participar desta pesquisa que tem como objetivo geral: Conhecer a percepção dos idosos que foram internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a infecção por vírus da covid-19 sobre a saúde mental antes e após a infecção pela Covid-19, e como objetivos específicos: Conhecer as publicações disponíveis sobre a saúde mental dos idosos antes e pós-pandemia, caracterizar o perfil sociodemográfico, econômico e de saúde dos idosos hospitalizados devido à infecção pela Covid-19, descrever os sentimentos relatados pelos idosos sobre a saúde mental antes e após a infecção pela Covid-19.

Para tanto, será aplicado aos indivíduos que concordarem em participar do referido estudo por meio da assinatura deste termo, um questionário contendo perguntas abertas e fechadas que exploram esse tema. Será facultado a opção de participar ou não da pesquisa, sem que haja benefício de qualquer natureza aqueles que optarem por participar e sem que haja prejuízo algum aqueles que optarem por não participar.

A coleta de dados será feita por meio de entrevistas aos participantes do estudo. Reforçamos que esta pesquisa visa como benefício colaborar a vislumbrar as consequências negativas impostas pelo vírus da covid-19 na saúde da população, principalmente dos idosos, desta forma, promovendo e incentivando pesquisas que possam destapar meios de prevenção e/ou tratamento. Além disso, poderá contribuir para os avanços científicos na área de saúde coletiva e saúde mental, bem como para as práticas de saúde. Os riscos envolvidos serão mínimos, podendo ser relacionados a desconforto em responder as perguntas. Todavia, todos os cuidados serão tomados para evitar qualquer constrangimento, exposição de danos de nenhuma natureza, tanto de ordem física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual.

Se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação (e/ou de seu filho) em qualquer etapa desta pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita. Havendo a ocorrência de danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caberá a você, na forma da Lei, o direito de solicitar a respectiva indenização.

Após ler, receber explicações sobre a pesquisa e conhecer meus direitos quanto a:

- Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimentos sobre a pesquisa;
- Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações;
- Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo,
- Procurar esclarecimentos com o Comitê de Ética em Pesquisa da Unioeste CEP/Unioeste, através do telefone (45) 3220-3272, em caso de dúvidas ou notificação de acontecimentos não previstos

Declaro estar ciente do exposto e desejo participar da pesquisa. Estou ciente que não receberei pagamento pela minha participação, que este termo será emitido em duas vias, sendo que uma delas me será fornecida.

Nome do sujeito de pesquisa ou responsável: _____

Assinatura: _____

Eu, _____, declaro que forneci todas as informações do projeto ao participante e/ou responsável.

Cascavel, _____ de _____ de 20 ____.

ANEXO

Anexo 1 – Parecer consubstanciado do CEP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: A SAÚDE MENTAL DOS IDOSOS QUE FORAM INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DEVIDO A INFECÇÃO PELO VÍRUS DA COVID-19

Pesquisador: Gicelle Galvan Machneski

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 84574424.8.0000.0107

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.261.355

Apresentação do Projeto:

O objetivo deste estudo é conhecer a percepção dos idosos que foram internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a infecção por vírus da covid-19 sobre a saúde mental antes e após a infecção pela Covid 19. Trata-se de um estudo de revisão de literatura, exploratório, descritivo, explicativo e de campo, com uma abordagem qualitativa, a ser realizado

com idosos que foram internados na UTI de um hospital universitário localizado na região oeste do Paraná. Para tanto, será realizada a busca de dados nos prontuários dos idosos que tiveram diagnóstico de covid-19 e entrevistas semiestruturadas, serão gravadas com dispositivo MP3, validadas pelos participantes e transcritas e analisadas através de método de Bardin. Acredita-se que este estudo deverá vislumbrar queixas de falhas de memória, percepção de aumento de ansiedade, depressão e insônia. Outrossim, poderá contribuir para os avanços científicos na área de saúde coletiva e saúde mental, bem como para as práticas de saúde. E em seguida, será abordada a segunda parte que compreenderá um estudo exploratório, descritivo, de campo com caráter qualitativo e de campo. A população do estudo será idosos que foram internados na UTI de um hospital universitário localizado no oeste do Paraná devido a infecção por vírus da covid-19. A relação

dessa população será solicitada junto ao setor da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), por meio de encaminhamento do projeto de

pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPEH).

Endereço: RUA UNIVERSITÁRIA 1619

Bairro: UNIVERSITÁRIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.261.355

A seleção dos participantes será feita por conveniência, com a obtenção da amostra quando ocorrer a saturação das informações coletadas quanto ao alcance dos objetivos (Fontanella; Ricas; Turato, 2008). Serão incluídos no estudo idosos com no mínimo sessenta (60) anos de idade, de ambos os sexos, que foram internados na

UTI por covid-19, e que concordaram em participar da pesquisa, sem restrições quanto à etnia, escolaridade ou classe social, e possuir condições cognitivas preservadas para assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Serão excluídos idosos que se encontrarão com enfermidade, e que não possuem a condição para responder as perguntas. Projeto para Dissertação de Mestrado. A coleta de dados será realizada em 2024, após a aprovação do projeto pelo comitê de ética em pesquisa. As coletas de dados serão conduzidas pessoalmente pelo próprio pesquisador por meio de entrevistas individuais, semi-estruturadas, realizadas in loco, nas residências dos participantes ou num local sereno acordado pelo (a) entrevistado (a).

Objetivo da Pesquisa:

Conhecer a percepção dos idosos que foram internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a infecção por vírus da covid-19 sobre a saúde mental antes e após a infecção pela Covid-19. As entrevistas abordarão questões sobre os dados sociodemográficos, como idade, sexo, estado civil, casado(a), solteiro(a), viúvo(a), divorciado(a),

raça, vínculo empregatício, entre outros. Também incluirão perguntas específicas sobre o tema do estudo, as quais questionará a respeito dos

sentimentos dos idosos durante a pandemia da covid-19 e como se sente agora; como o isolamento social influenciou nas suas vidas cotidianas; se

conhece alguém que sofreu com a covid-19 e de que maneira esse sofrimento afetou as suas vidas; como se avaliam o funcionamento das suas

memórias antes e após infecção por covid-19; se a infecção por covid-19 afetou o sono. As perguntas e respostas serão gravadas com dispositivo

MP3 e posteriormente transcritas. A transcrição das entrevistas será realizada na íntegra e, em seguida, submetida à técnica de análise de conteúdo

proposta por Bardin (2004), que inclui três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

A apresentação dos resultados será feita por meio do método de categorias, permitindo a classificação dos componentes do significado da mensagem. Os participantes serão identificados com a expressão S1, seguida do número ordinal da entrevista (1; 2; 3...), garantindo seu anonimato.

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE**



Continuação do Parecer: 7.261.355

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos: . Acredita-se que os riscos envolvidos nesta pesquisa serão mínimos. No entanto, todos cuidados serão tomados para eliminar ou minimizar esses riscos. As identidades, assim como as respostas dos participantes será mantido em absoluto sigilo, e todos arquivos serão destruídos. Se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação (e/ou de seu filho) em qualquer etapa desta pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita. Havendo a ocorrência de danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caberá a você, na forma da Lei, o direito de solicitar a respectiva indenização posteriormente.

Benefícios: Esta pesquisa terá como benefício a elucidação das condições mentais dos idosos hospitalizados por covid-19, permitindo assim, o desenvolvimento de estratégias de cuidado.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Segue normas da Resolução 466/12 e/ou 510/16 e CNS/MS e suas complementares.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Termos de apresentação obrigatória: todos foram anexados e devidamente assinados, incluindo instituição coparticipante.

Recomendações:

não há

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Segue normas da Resolução 466/12 e/ou 510/16 e CNS/MS e suas complementares.

Considerações Finais a critério do CEP:

Aprovado.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2433489.pdf	08/11/2024 10:00:09		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Brochura_projeto.pdf	07/11/2024 14:00:41	Gicelle Galvan Machineski	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento /	TCLE2.pdf	07/11/2024 13:58:33	Gicelle Galvan Machineski	Aceito

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prpg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.261.355

Justificativa de Ausência	TCLE2.pdf	07/11/2024 13:58:33	Gicelle Galvan Machineski	Aceito
Folha de Rosto	Folha_de_rosto1.pdf	07/11/2024 13:57:24	Gicelle Galvan Machineski	Aceito
Outros	Formulario_CEP_AnexosIaIV.pdf	05/10/2024 10:50:20	Gicelle Galvan Machineski	Aceito
Outros	Instrumentodecoletadedados.pdf	05/10/2024 10:37:48	Gicelle Galvan Machineski	Aceito
Outros	Termodecompromissopesquisador.pdf	05/10/2024 10:30:13	Gicelle Galvan Machineski	Aceito
Outros	Termodecompromissousodedados.pdf	05/10/2024 10:29:14	Gicelle Galvan Machineski	Aceito
Outros	Declaracaodepesquisanaoiniciada.pdf	05/10/2024 10:28:22	Gicelle Galvan Machineski	Aceito
Outros	Termo_de_ciencia_pelo_campo_do_estudo.pdf	04/10/2024 11:17:09	Gicelle Galvan Machineski	Aceito
Outros	Termo_autorizacao_de_pesquisa.pdf	04/10/2024 11:16:50	Gicelle Galvan Machineski	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCADEL, 02 de Dezembro de 2024

Assinado por:

Fausto José da Fonseca Zamboni
(Coordenador(a))

Anexo 2 – Comprovante de submissão do artigo para publicação

Gmail - [ArqSaude] Agradecimento pela submissão

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=df3aa66adb&view=pt&search=al..>

Rosa Maria Rodrigues <rmrodri09@gmail.com>

[ArqSaude] Agradecimento pela submissão

Prof. Me. Nelton Anderson Bespalez Corrêa - Editor via Portal de Periódicos da UNIPAR
<ojs@unipar.openjournalsolutions.com.br>

23 de fevereiro de
2026 às 08:34

Responder a: "Prof. Me. Nelton Anderson Bespalez Corrêa - Editor" <arqsaude@unipar.br>

Para: Dra Rosa Maria Rodrigues <rmrodri09@gmail.com>

Dra Rosa Maria Rodrigues:

Obrigado por submeter o manuscrito, "REPERCUSSÕES MENTAIS E FÍSICAS EM IDOSOS APÓS INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA POR COVID-19" ao periódico Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR. Com o sistema de gerenciamento de periódicos on-line que estamos usando, você poderá acompanhar seu progresso através do processo editorial efetuando login no site do periódico:

URL da Submissão: <https://www.revistas.unipar.br/index.php/saude/authorDashboard/submission/12644>

Usuário: rosa_maria

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Agradecemos por considerar este periódico para publicar o seu trabalho.

Prof. Me. Nelton Anderson Bespalez Corrêa - Editor

Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR
<http://www.revistas.unipar.br/index.php/saude>